Boletín Epidemiológico N° 01 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

Ministerio de Salud

17 de enero de 2025

Tabla de contenido

Arbovirosis 3

Malaria 14

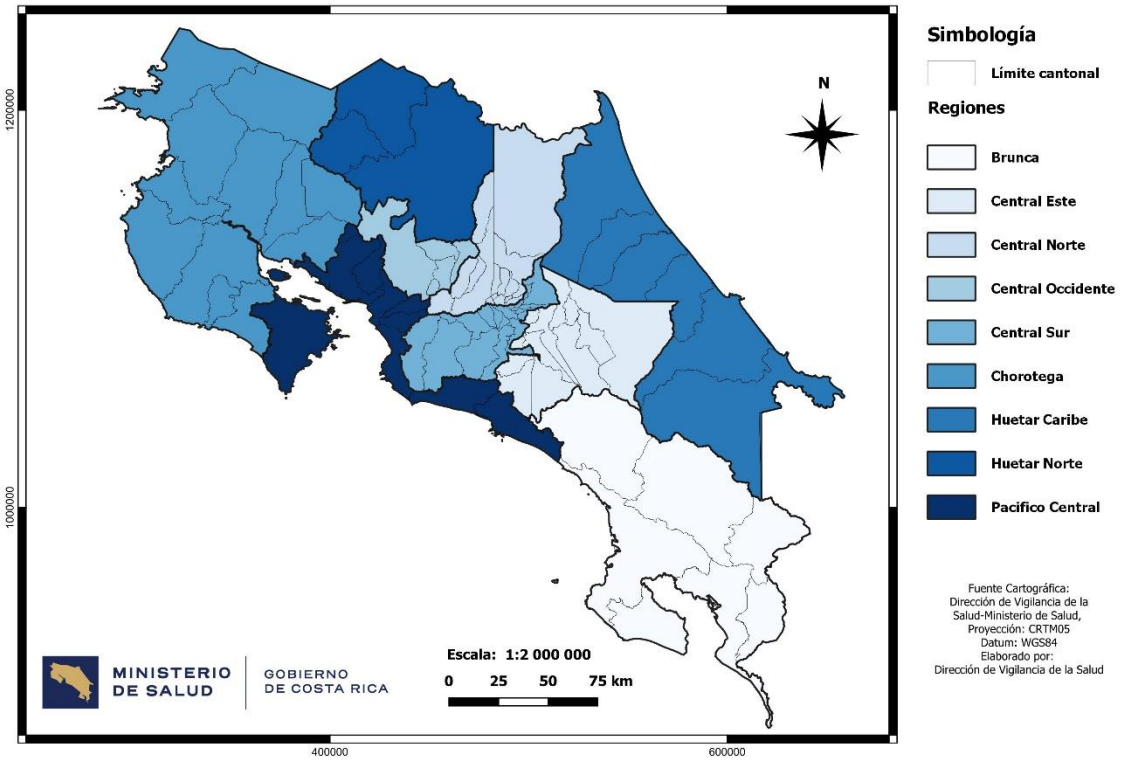
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19 22

Intoxicación por metanol 39

Infecciones de transmisión sexual 43

Costa Rica: información sobre los femicidios 56

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud

Adrián Montero Bonilla
Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Dengue

Preliminarmente a la semana epidemiológica 52 del año 2024 se notificaron **31259 casos** de dengue, de estos **195 casos** acumulados han sido notificados como dengue con signos de alarma.

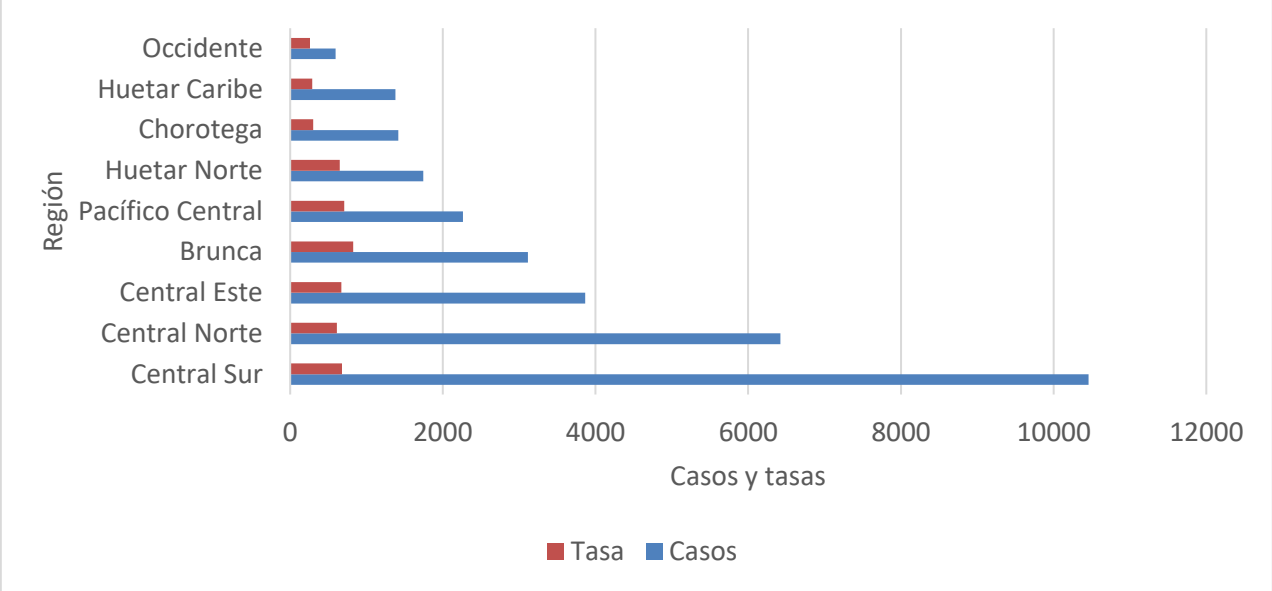
En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 10458 casos y la región con mayor tasa 825,9/100.000 habitantes en la Brunca.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 52, 2024 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Sur	10458	678,2
Central Norte	6422	613,8
Central Este	3863	671,8
Brunca	3115	825,9
Pacífico Central	2265	706,7
Huetar Norte	1744	649,1
Chorotega	1418	300,4
Huetar Caribe	1380	288,0
Occidente	594	259,6
Total	31259	588,7

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 1.
Costa Rica: casos de dengue y tasa por región a la semana epidemiológica 52, 2024.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

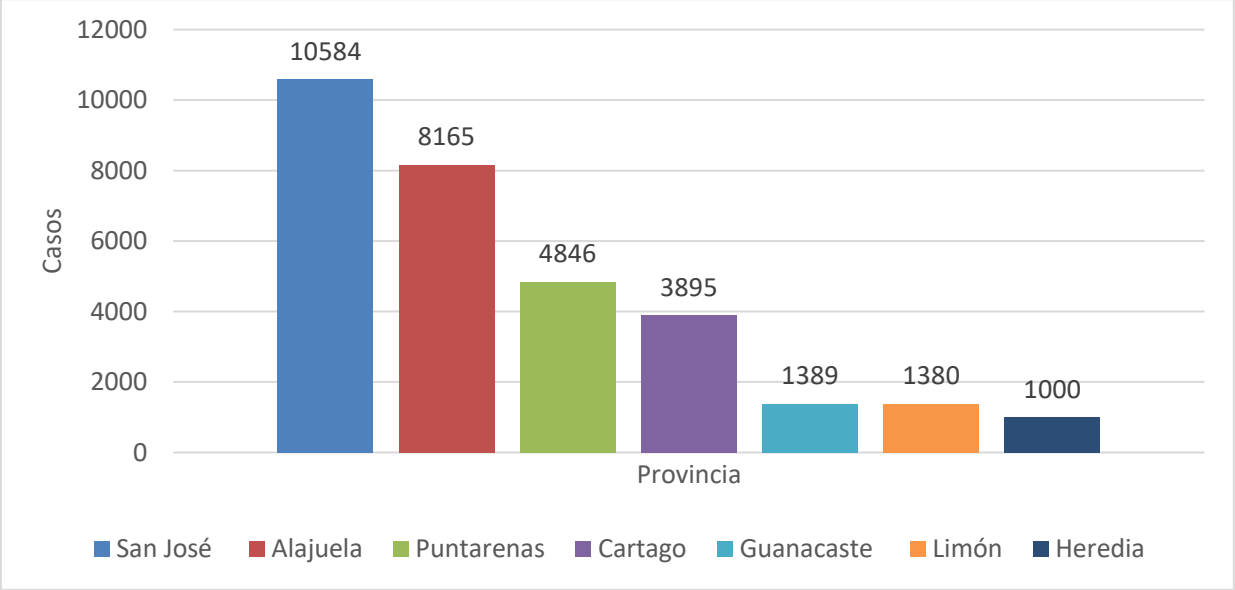
En la tabla 2 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2024.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2024

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
San José	10584	620,1	5643	657,1	4941	582,6
Alajuela	8165	755,6	4170	780,8	3995	731,1
Puntarenas	4846	928,5	2537	989,1	2309	870,0
Cartago	3895	703,8	2163	783,9	1732	624,1
Guanacaste	1389	334,5	676	330,2	713	338,7
Limón	1380	288,0	625	268,3	755	306,7
Heredia	1000	181,0	497	180,5	503	181,5
Total	**31259**	**588,7**	**16311**	**618,2**	**14948**	**559,6**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia a la semana epidemiológica 52, 2024.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 52 son: San José 4449 casos, Alajuela 3320 casos, Turrialba 3028 casos, San Carlos 1509 casos y Alajuelita 1460 casos.

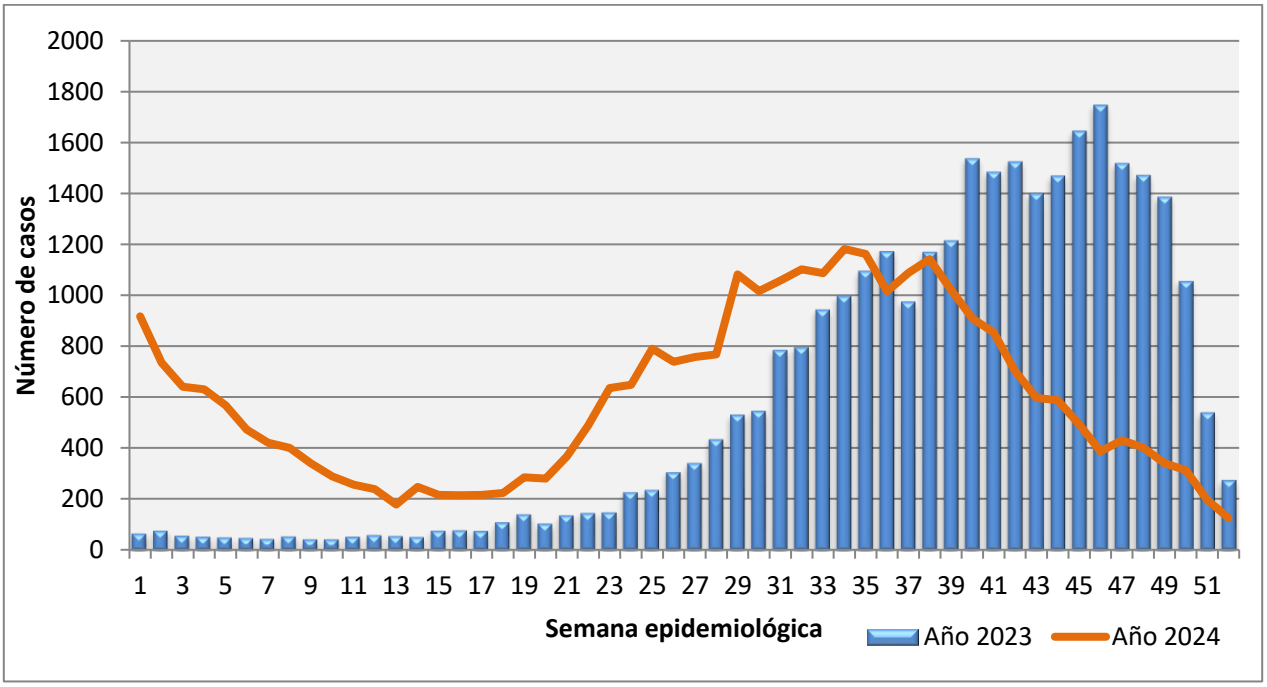
Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios en casos de dengue a la semana epidemiológica 52, Costa Rica 2024

Cantón	Casos	Tasa
101: San José	4449	1249,5
201: Alajuela	3320	1008,6
305: Turrialba	3028	4127,7
210: San Carlos	1509	712,3
110: Alajuelita	1460	1465,4
109: Santa Ana	1423	2252,4
103: Desamparados	1414	558,5

205: Atenas	1175	3864,8
603: Buenos Aires	1143	2037,5
605: Osa	860	2722,6
601: Puntarenas	770	522,0
610: Corredores	671	1230,9
304: Jiménez	577	3520,0
203: Grecia	438	445,1
702: Pococí	401	253,0
107: Mora	375	1203,5
207: Palmares	373	874,7
602: Esparza	366	909,1
410: Sarapiquí	349	378,0
113: Tibás	347	398,1

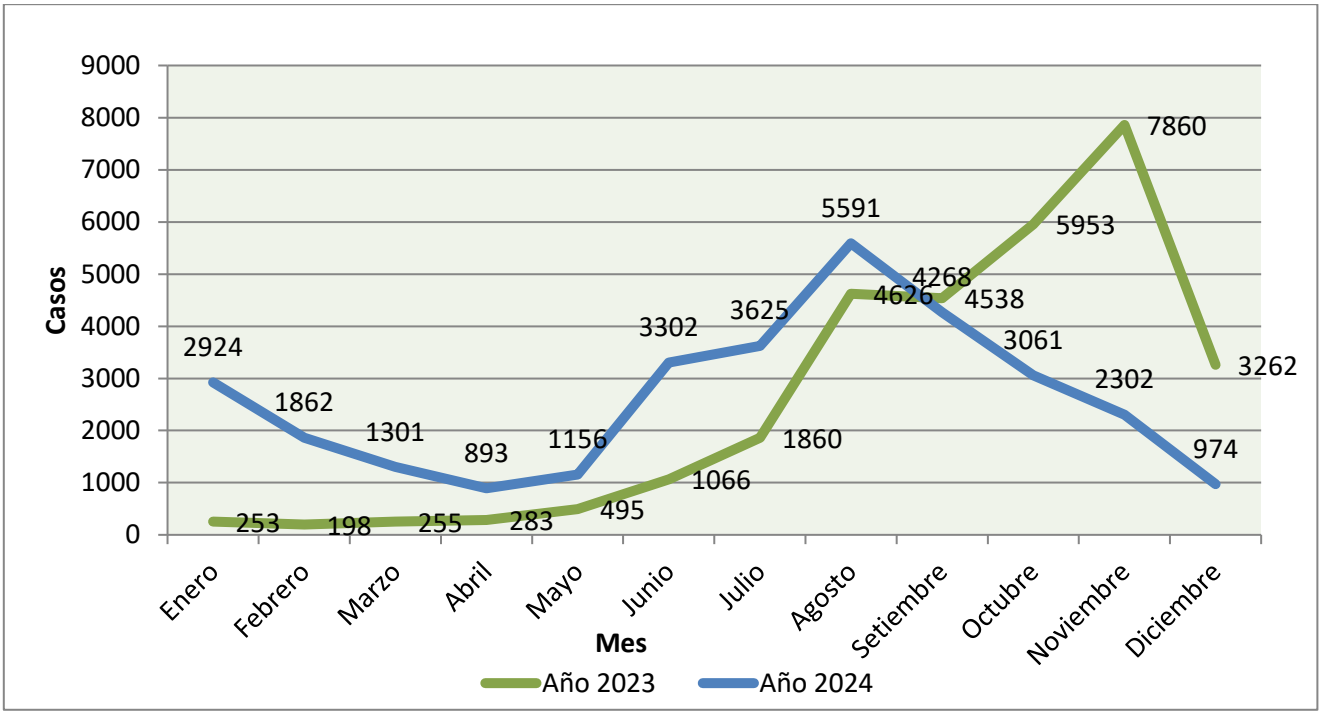
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Figura 3.
Costa Rica: Casos de dengue notificados a la semana epidemiológica 52, 2023-2024



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 4.
Costa Rica: casos de dengue notificados por mes, 2023-2024



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Tabla 4.
Costa Rica: Casos notificados de dengue a la semana epidemiológica 52, 2023-2024

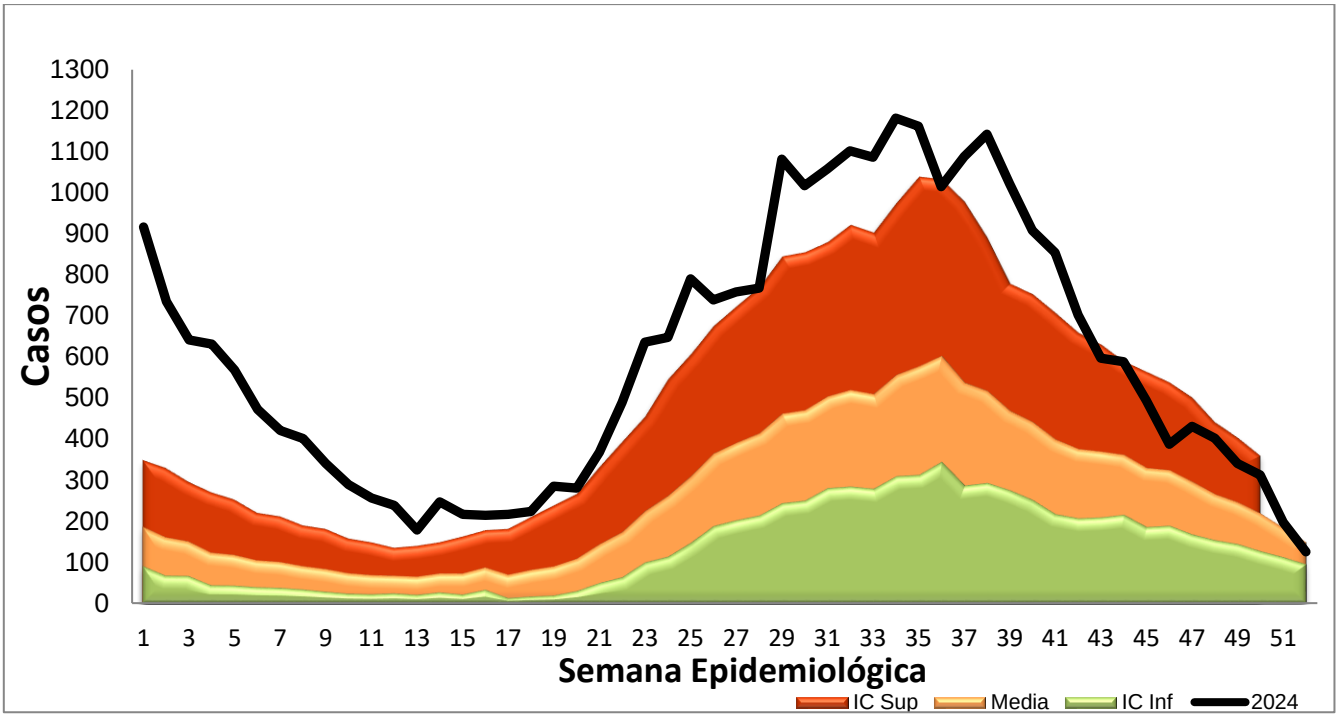
Semana	2023	2024
1	66	917
2	77	735
3	57	641
4	53	631
5	51	568
6	48	472
7	44	421
8	55	401
9	43	340

10	43	289
11	53	256
12	60	238
13	56	178
14	52	247
15	77	216
16	78	214
17	76	216
18	110	223
19	142	285
20	105	280
21	138	368
22	146	489
23	149	636
24	228	648
25	237	790
26	306	739
27	343	758
28	436	768
29	533	1082
30	548	1017
31	787	1058
32	798	1102
33	945	1087
34	999	1182
35	1097	1162
36	1174	1015
37	976	1088
38	1171	1143
39	1217	1022
40	1539	908
41	1486	854
42	1526	702
43	1402	597
44	1471	588
45	1647	494

46	1749	387
47	1520	431
48	1473	402
49	1388	340
50	1057	312
51	541	197
52	276	125
Total	**30649**	**31259**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

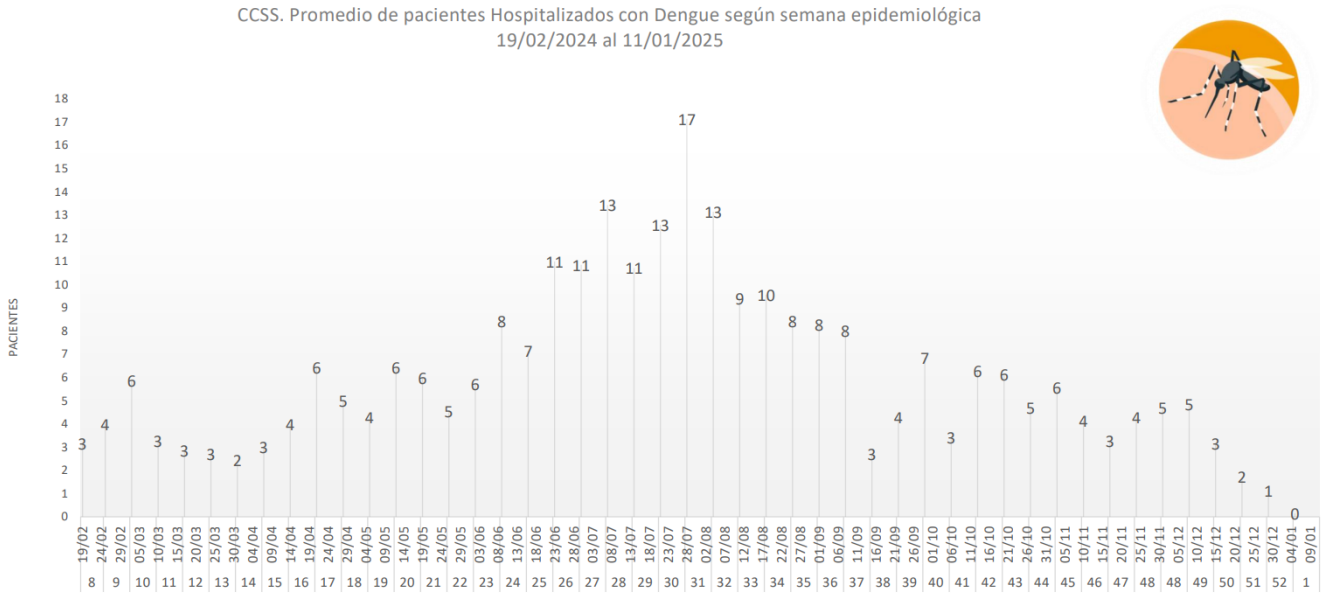
Figura 5.
Canal endémico dengue, Costa Rica 2024.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

El Área de Estadística en Salud de la CCSS según los datos recopilados mediante EDUS no se reportan pacientes hospitalizados con dengue al 13 de enero.

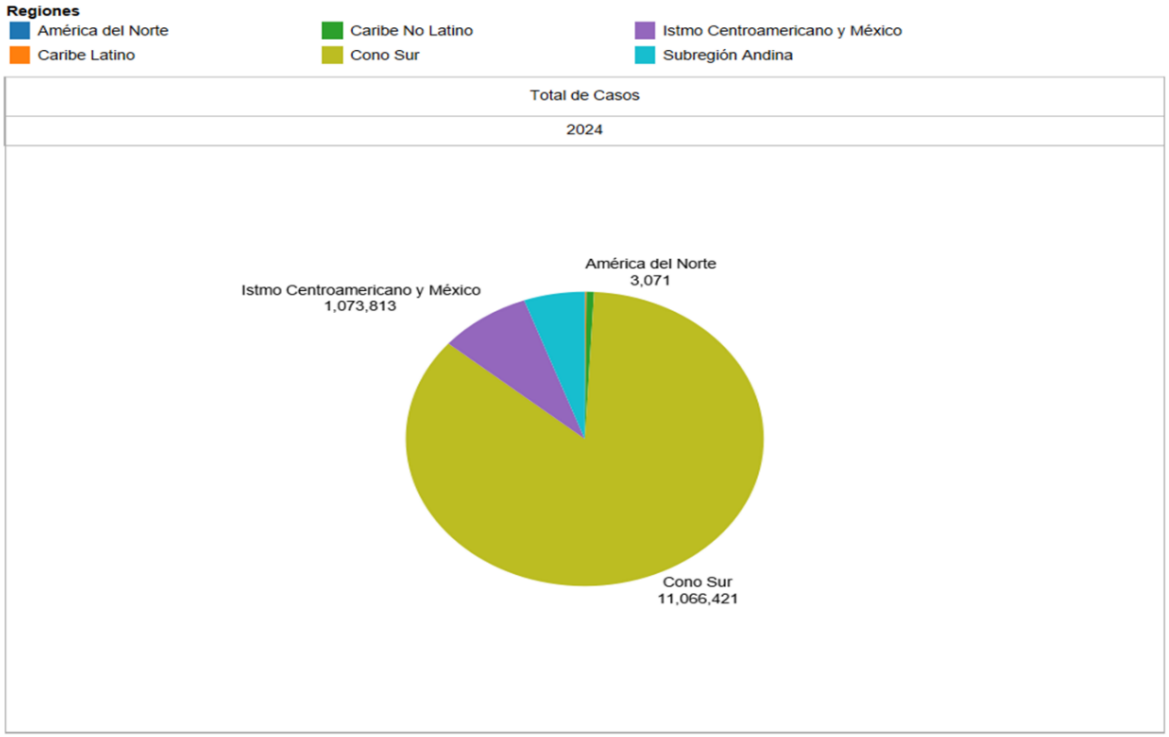
Figura 6.
Costa Rica: Promedio de pacientes hospitalizados con dengue según semana epidemiológica del 19/02/2024 al 11/01/2025



Fuente: EDUS CCSS, Gerencia Médica, Área de estadística en salud

La región de las Américas que abarca: América del Norte, Caribe Latino, Caribe no Latino, Cono Sur, Subregión Andina el Istmo Centroamérica y México reporta preliminarmente un total de 12.958.210 casos de dengue de estos 22.511 casos graves y un total de 8.129 muertes.

Figura 7.
Casos de dengue reportados en las Américas, 2024



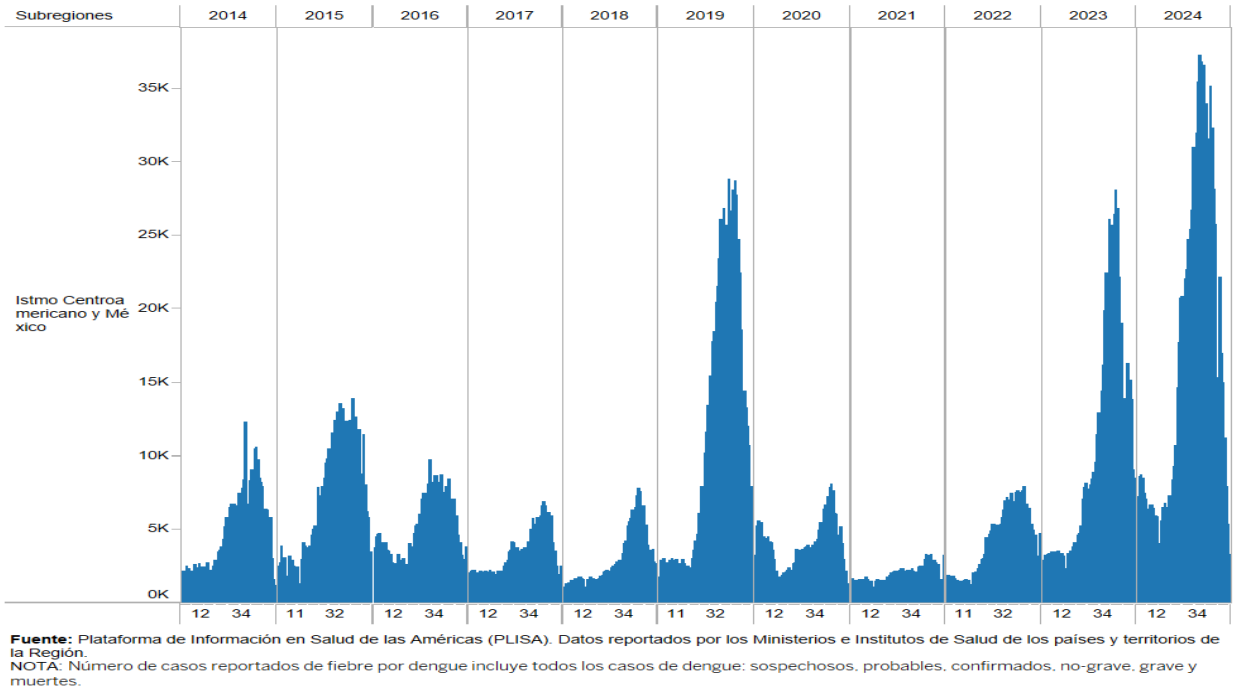
Fuente: Plataforma de información en Salud de las Américas (PLISA), OPS

Tabla 5
Casos notificados de dengue en el Istmo centroamericano y México, 2024

País	2024			
	Dengue	Dengue grave	Total	Muertes
Belice	1 144	4	1 148	0
Costa Rica	30 389	195	30 389	7
El Salvador	8 002	29	8 031	9
Guatemala	184 294	207	184 501	188
Honduras	174 959	2 250	177 209	160
México	554 632	4 214	558 846	478
Nicaragua	79 306	16	79 322	1
Panamá	34 044	323	34 367	49
Total	**1 066 770**	**7 238**	**1 073 813**	**892**

Fuente: Plataforma de información en Salud de las Américas (PLISA), OPS

Figura 8.
Casos de dengue reportados en el Istmo Centroamericano y México, 2014-2024



Fuente: Plataforma de Información en Salud de las Américas (PLISA). Datos reportados por los Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región.
NOTA: Número de casos reportados de fiebre por dengue incluye todos los casos de dengue: sospechosos, probables, confirmados, no-grave, grave y muertes.

Fuente: Plataforma de información en Salud de las Américas (PLISA), OPS

Chikungunya

Se registran 45 casos reportados a través de notificación obligatoria por boleta VE01 de chikungunya a la semana epidemiológica 52, ninguno confirmado por PCR.

Tabla 6

Costa Rica: Casos y tasas de Chikungunya por región a la semana epidemiológica 52, 2024 (Tasa por 100.000 hab.).

Región	Casos	Tasa
Central Norte	10	1,0
Central Sur	9	0,6
Brunca	6	1,6
Chorotega	6	1,3
Pacífico Central	6	1,9
Huetar Caribe	3	0,6
Huetar Norte	3	1,1
Central Este	2	0,3
Occidente	0	0,0
Total	45	0,8

Fuente: Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud

Zika

Se registran 32 casos a través de notificación obligatoria por boleta VE01 de zika, a la semana epidemiológica 52, ninguno confirmado por PCR.

Tabla 7

Costa Rica: Casos y tasas de Zika por Región a la semana epidemiológica 52, 2024 (Tasa por 100.000 hab.).

Región	Casos	Tasa
Chorotega	9	1,9
Central Sur	8	0,5
Central Norte	5	0,5
Pacífico Central	5	1,6
Central Este	2	0,3
Brunca	1	0,3
Huetar Caribe	1	0,2
Huetar Norte	1	0,4
Occidente	0	0,0
Total	32	0,6

Fuente: Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

I. Antecedentes.

En las últimas décadas, Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria. Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.
Costa Rica forma parte de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM) es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

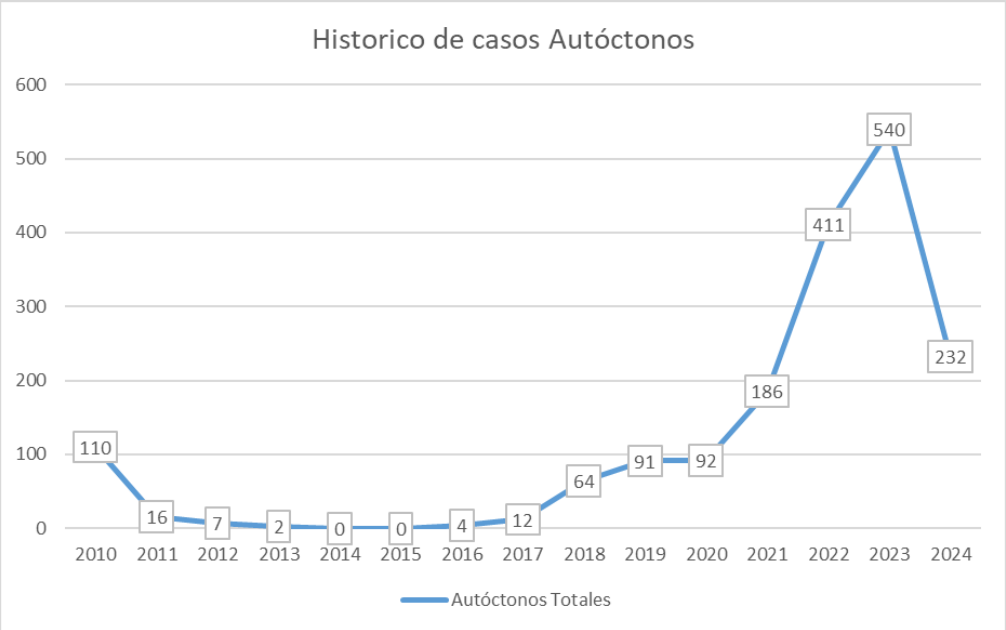
II. Comportamiento

Durante el periodo de vigilancia reciente, se han registrado un total de 321 casos de malaria distribuidos en distintas especies y clasificaciones epidemiológicas. A continuación, se presentan de manera preliminar los datos detallados:

- ***Plasmodium falciparum***: Constituye la mayoría de los casos, con un total de 233 reportes. De estos, 223 son casos autóctonos, mientras que se han registrado 5 casos importados, 5 casos pendientes de clasificación.
- ***Plasmodium vivax***: Se han detectado 85 casos en total. De estos, 9 son autóctonos, 67 son importados, 3 clasificado como introducido, 6 están pendientes de clasificación.
- ***Plasmodium malariae***: Solo se han identificado 2 casos, clasificados como importados.
- ***Plasmodium ovale***: Se registra 1 caso importado, sin casos autóctonos o en otras clasificaciones.

Clasificación general: La mayoría de los casos (N=233) son autóctonos, considerando los casos introducidos (N = 3), mientras que los casos importados suman 75. Además, se reportan 11 casos en estudio.
Estos datos subrayan la prevalencia de *P. falciparum* en los casos autóctonos, mientras que *P. vivax* es la especie más frecuente entre los casos importados. La vigilancia continúa siendo crucial para identificar y clasificar los casos de manera adecuada y así poder tomar decisiones informadas en el control y la prevención de la malaria en la región.
A continuación, se muestra el registro histórico de casos autóctonos en el país a Semana Epidemiológica (SE) 52.

Gráfico 1.
Costa Rica: Total de casos autóctonos de Malaria por año, desde 2010 a SE 52, 2024.

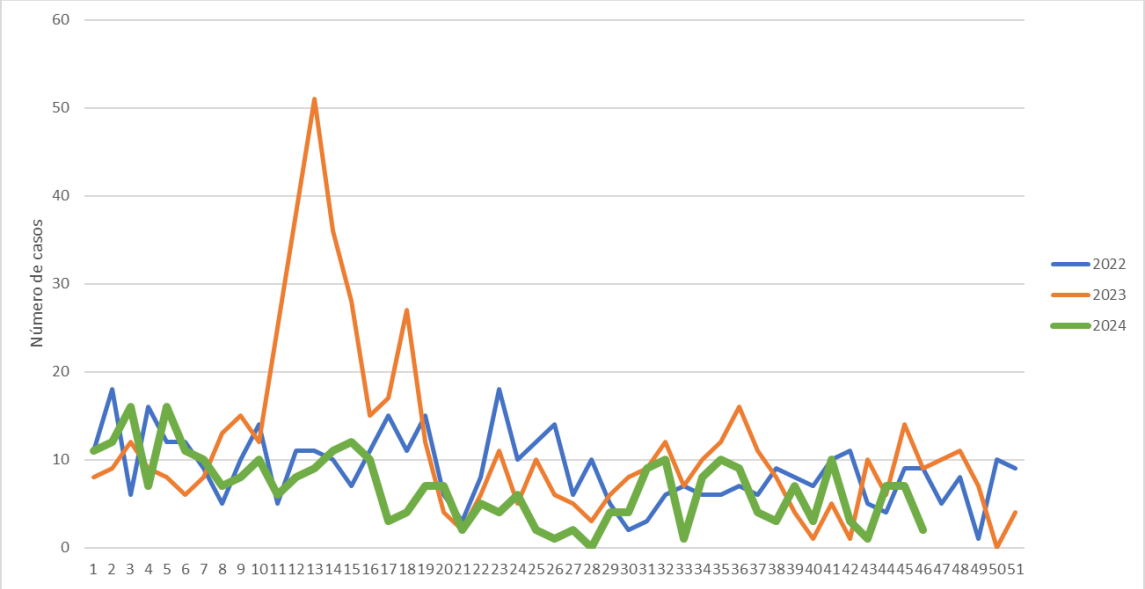


Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

En el año 2022, se registraron un total de 411 casos autóctonos de malaria. En el año siguiente, 2023, se reportaron 535 casos autóctonos. Por lo tanto, hubo un incremento aproximado del 30% en los casos de malaria del 2022 al 2023.
Se registraron casos en siete regiones, sin embargo, más del 80% de los casos pertenecen a dos regiones Huetar Norte y Huetar Caribe. La región con más casos

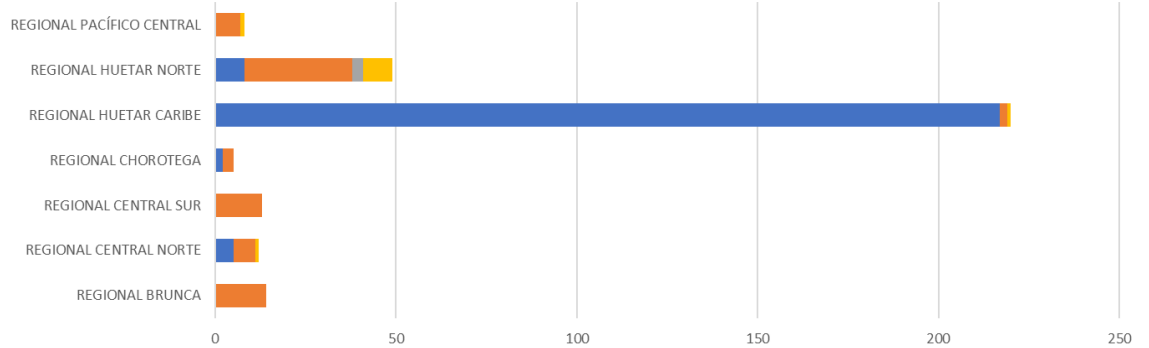
reportados fue la Huetar Caribe donde se reactivaron dos focos (Limón y Matina) y se intensificó la transmisión en uno de los focos activos (Jardín).
Mientras que en la región Huetar Norte, a pesar de ser la segunda región con más casos durante el 2023 detuvo la transmisión local posterior a una administración masiva de medicamentos en la SE 16. En ambas regiones, predominaron los casos por *Plasmodium falciparum.*
Por otro lado, se produjo un brote *por Plasmodium vivax* en la región Brunca, en la frontera sur del país, asociado a la ruta de movilidad humana por Centroamérica.

Gráfico 2.
Costa Rica: Comportamiento de casos totales en los años 2022, 2023 y 2024.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos reportados por región según clasificación epidemiológica a semana 52, 2024.



	REGIONAL BRUNCA	REGIONAL CENTRAL NORTE	REGIONAL CENTRAL SUR	REGIONAL CHOROTEGA	REGIONAL HUETAR CARIBE	REGIONAL HUETAR NORTE	REGIONAL PACÍFICO CENTRAL
AUTÓCTONO	0	5	0	2	217	8	0
IMPORTADO	14	6	13	3	2	30	7
INTRODUCIDO	0	0	0	0	0	3	0
PENDIENTE	0	1	0	0	1	8	1

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

A continuación, se presenta el listado de las comunidades en las que se han detectado casos en las últimas 8 semanas:

Tabla 2.
Costa Rica: Listado de las comunidades en las que se han detectado casos en las últimas 8 semanas.

Cantón	Distrito	Localidad	Total
Corredores	**Canoas**	Canoas	2
Matina	**Carrandi**	Estrada	14
		La Maravilla	1
		Saborío	3
	Matina	Corina	1
		Goli	1
Pococí	**Rita**	El Rotulo	1
		La Suerte	3
San Carlos	**Cutris**	Crucitas	3
		Las Chorreras	3
	Pocosol	San Isidro	1
Heredia	**Heredia**	Fátima	1
Hojancha	**Hojancha**	Viento Fresco	1
Total General			**35**

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

III. Vigilancia epidemiológica

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos. Las búsquedas activas realizadas por los inspectores de salud del Minsa y pasivas ejecutadas por colaboradores voluntarios y CCSS.

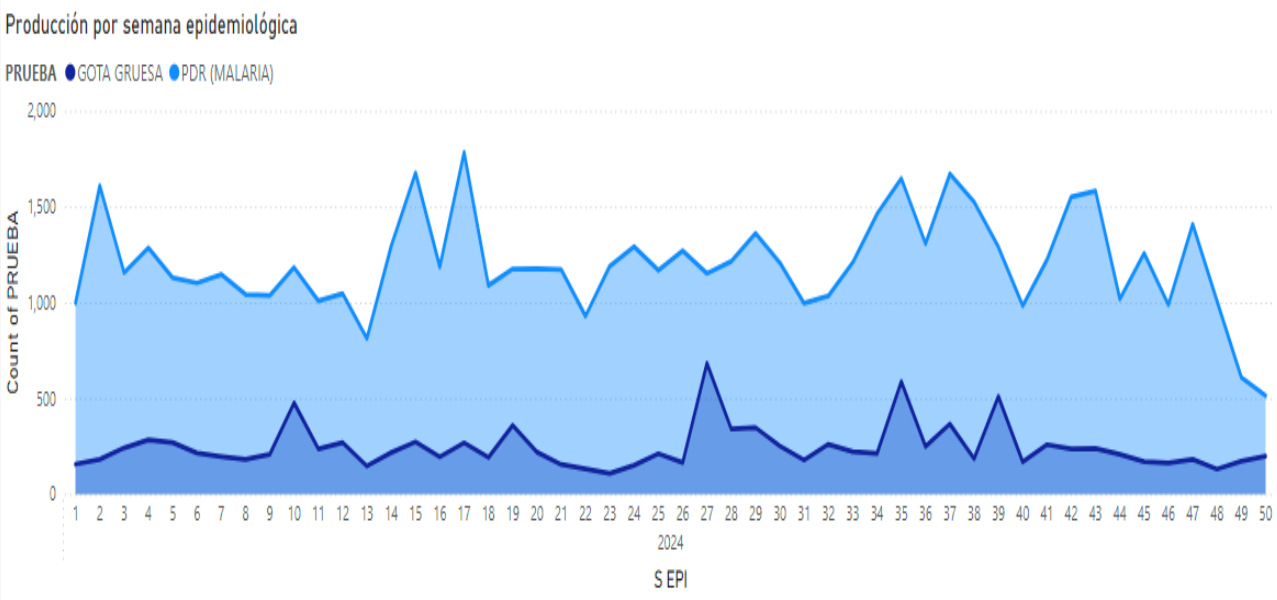
A semana epidemiológica 52, se registraron de manera preliminar 64162 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- Gotas gruesas: 9984 (sin considerar muestras de seguimiento)
- Pruebas de diagnóstico rápido: 59086
  - Realizadas por CCSS: 38229
  - Realizadas por ColVol: 629
  - Realizadas por Inspector de salud: 19354
  - Realizadas por otros: 629

Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.

Nota: El registro puede incluir datos duplicados, ya que se toman en cuenta las Gotas Gruesas (GG) para medir la parasitemia antes de iniciar el tratamiento, ante una Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) positiva: Inventario de focos.

Figura 1.
Costa Rica: Producción de pruebas de diagnóstico de malaria a nivel nacional, consolidado CCSS y Minsa



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica y CCSS.

IV. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 8 focos activos, 9 focos residuales inactivos y 4 focos eliminados.

Figura 2.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a enero 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

V. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 3.
Costa Rica: Listado de Focos de malaria a enero 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Activo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Activo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19

Roberto Arroba Tijerino
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Mayra Quesada Sanabria
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

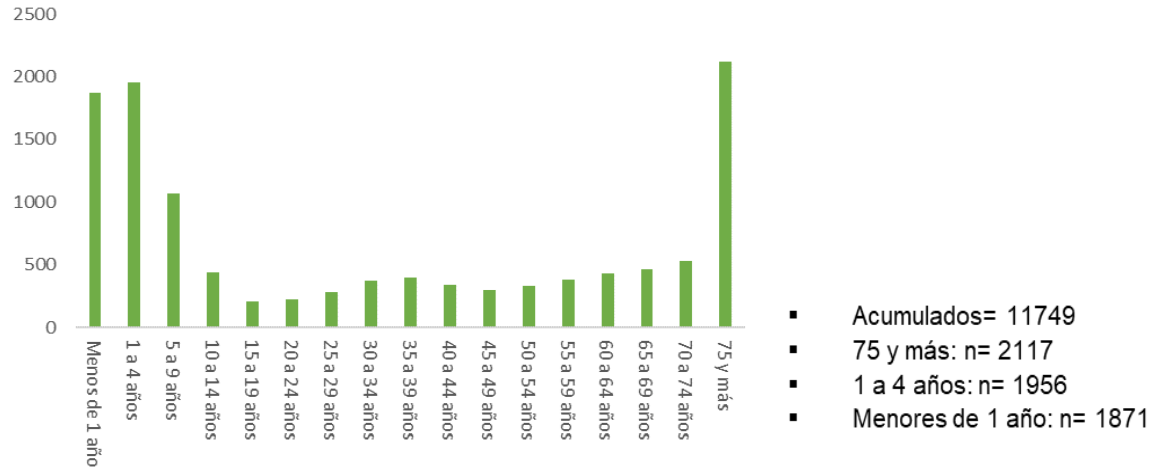
Rafael Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 52 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 52 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 52 son un total de 11749.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños entre 1 y 4 años y en los mayores de 75 años.

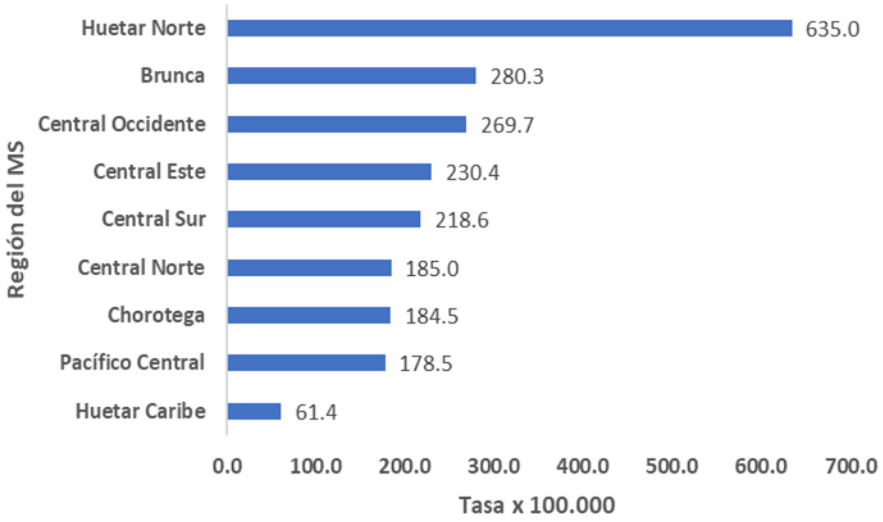
Gráfico 1.
Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 52, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños entre 1 y 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).
En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 52, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Huetar Norte, Brunca, Central Occidente y Central Este y Central Sur; las regiones con menor incidencia corresponden a la Pacífico Central, Central Norte, Chorotega y Huetar Caribe.

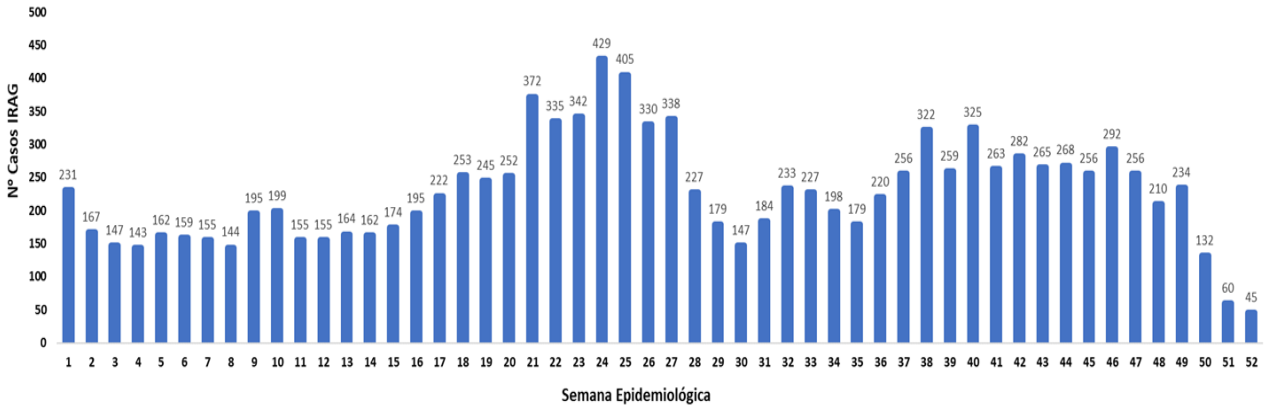
Gráfico 2.
Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 52 del 2024, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 52 del año 2024.

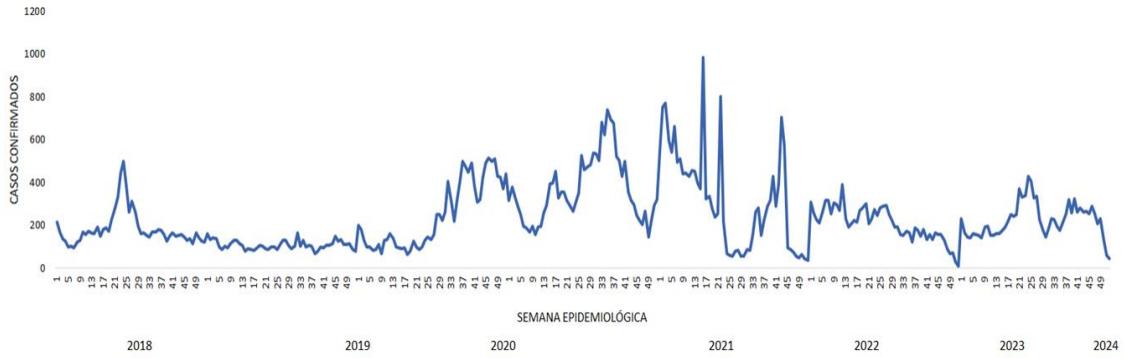
Gráfico 3.
Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 52, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2024, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

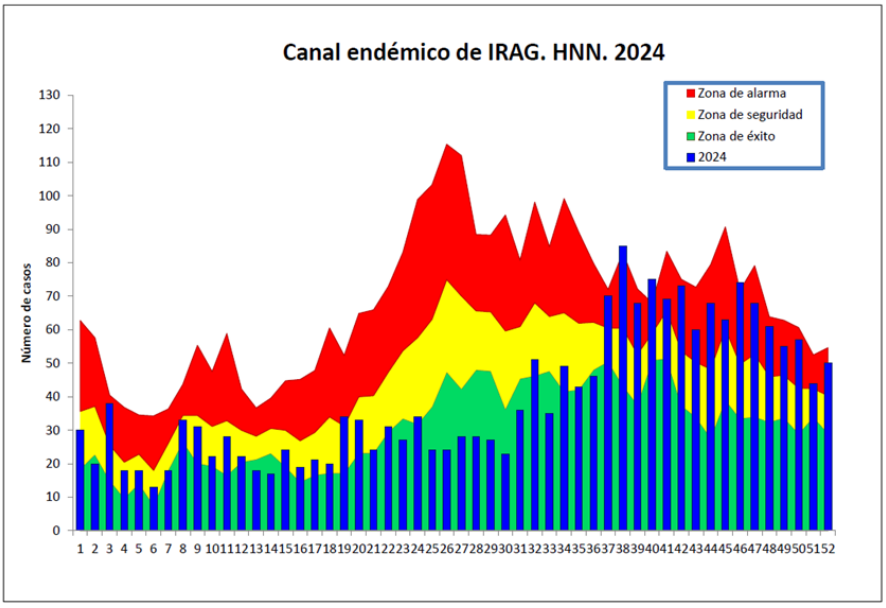
Gráfico 4.
Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

El HNN, para la SE-52 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra en la zona de alarma debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

Gráfico 5.
Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2024

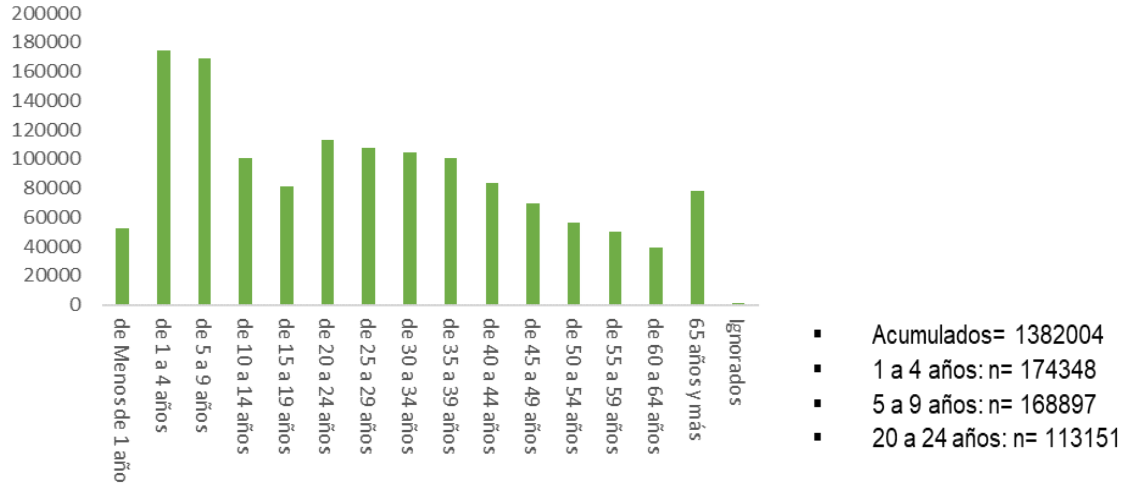


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2024.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 52 son 1382004.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en menores entre 1 y 4 años y niños entre 5 y 9 años.

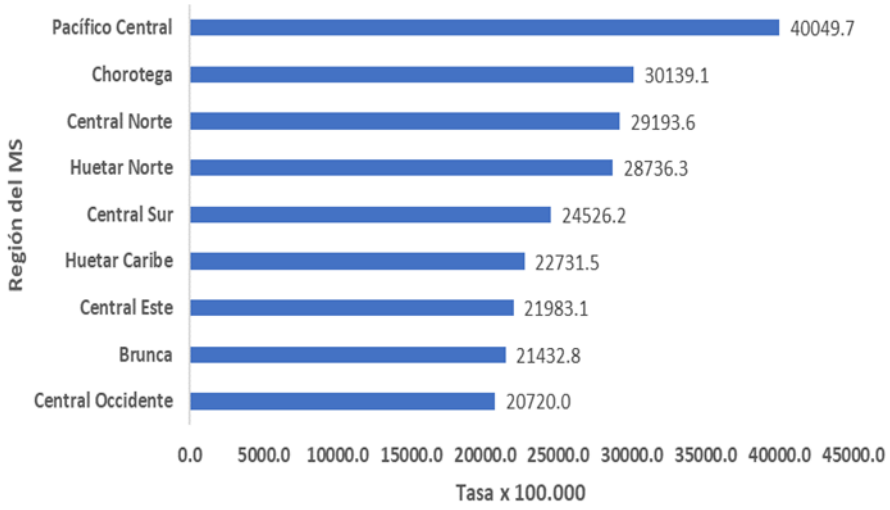
Gráfico 6.
Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 52, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 52, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Pacífico Central, seguido de la Chorotega, la Central Norte, la Huetar Norte y la Central Sur. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Huetar Caribe, la Central Este, la Brunca y la Central Occidente.

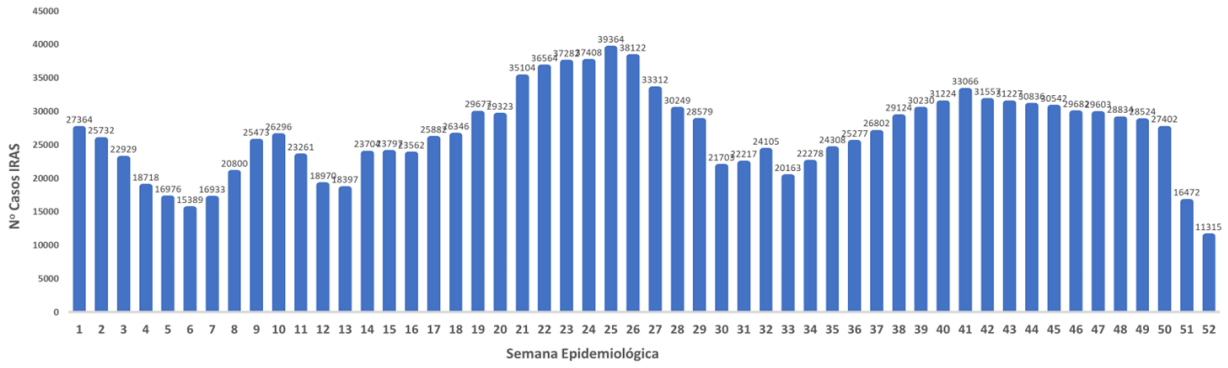
Gráfico 7.
Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 52 del 2024, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado a lo largo de estas 52 semanas epidemiológicas del año 2024.

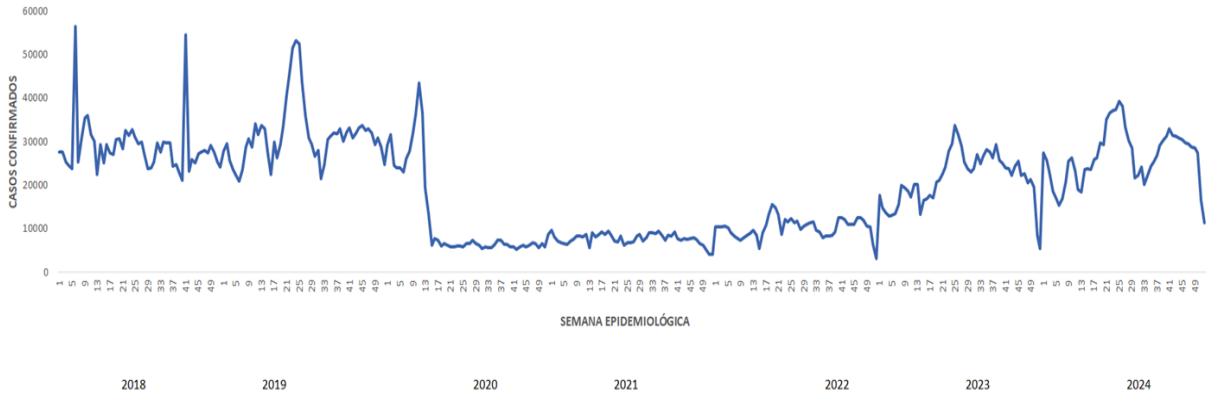
Gráfico 8.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 52, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2024, esto se puede apreciar en el gráfico 9.

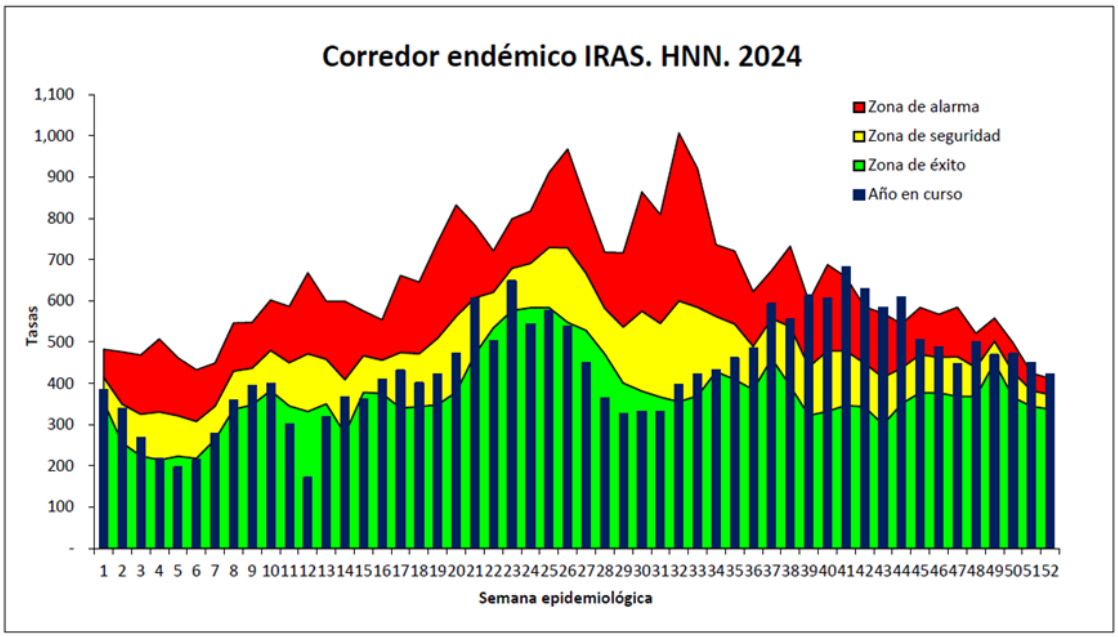
Gráfico 9.
Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 52 se encuentran en la zona de seguridad actualmente.

Gráfico 10.
Costa Rica: Canal endémico IRAS. HNN. 2024.

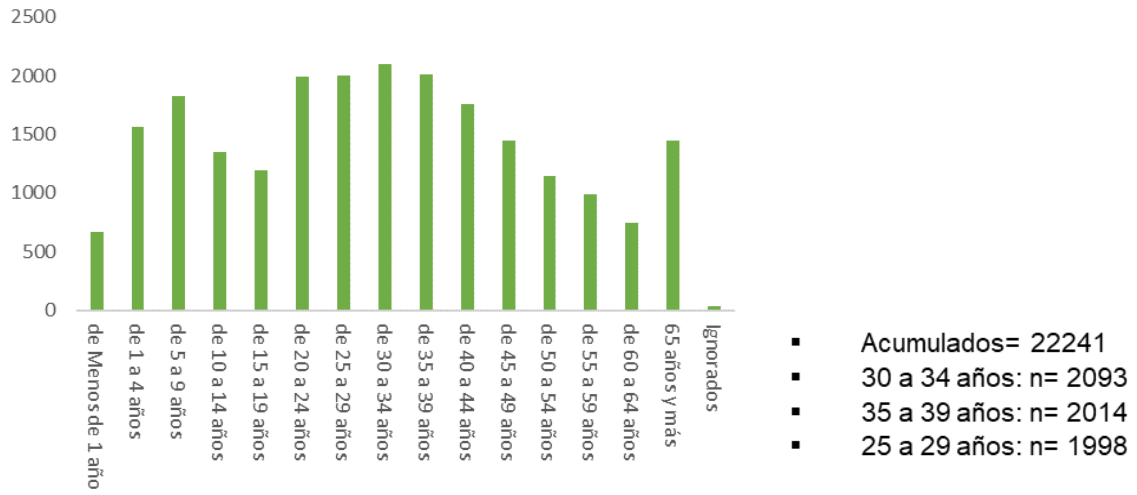


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2024.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 52 son n= 22241.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 30 y 34 años y las personas entre 35 y 39 años.

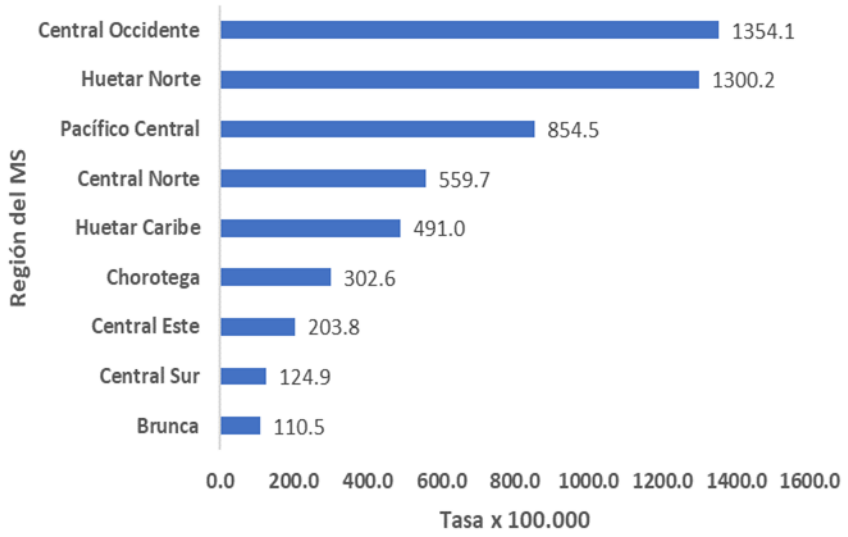
Gráfico 11.
Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 52, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 52, presentando mayor cantidad de casos en la región la Central Occidente, Huetar Norte, la Pacífico Central, la Central Norte y la Huetar Caribe. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Brunca, la Chorotega, la Central Este y la Central Sur.

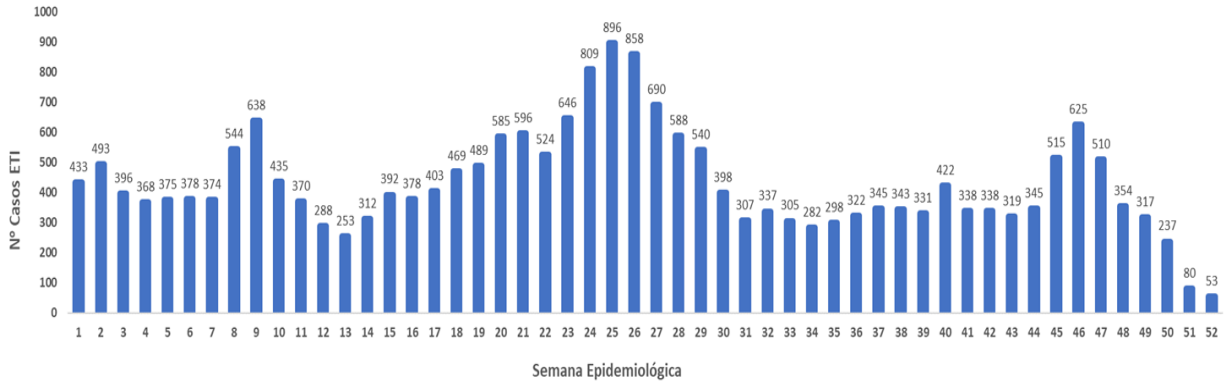
Gráfico 12.
Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 52 del 2024, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2024.

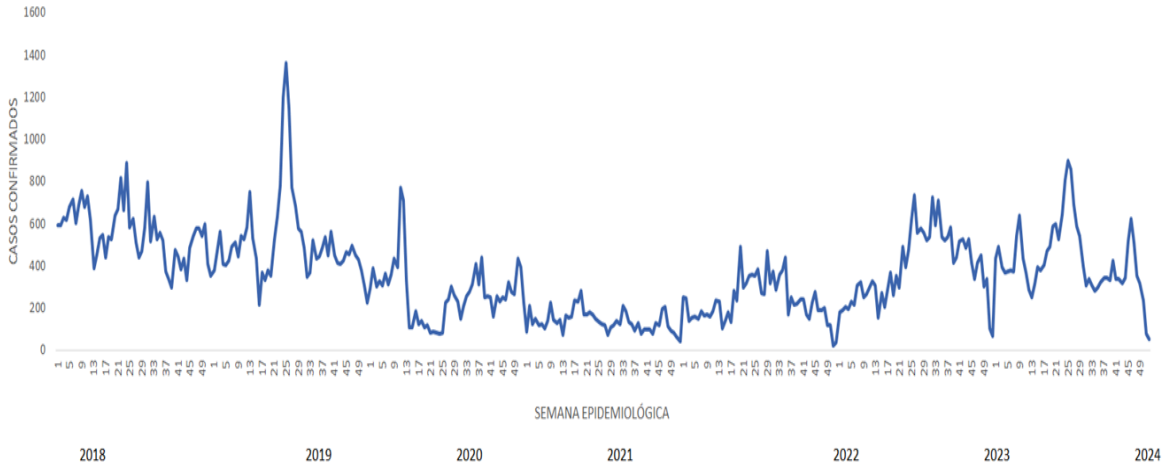
Gráfico 13.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 52, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2024, esto se puede apreciar en el gráfico 14.

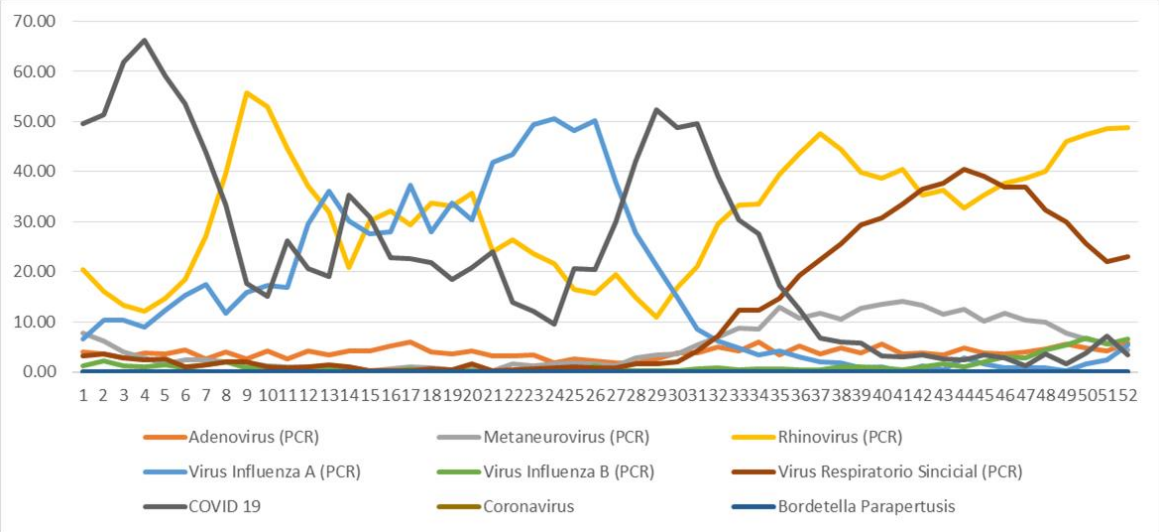
Gráfico 14.
Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 52; para la SE-52, en el país el Rinovirus es el que más está circulando, seguido del Virus Sincicial Respiratorio, y finalmente, el virus de influenza estacional está en tercer lugar de circulación.

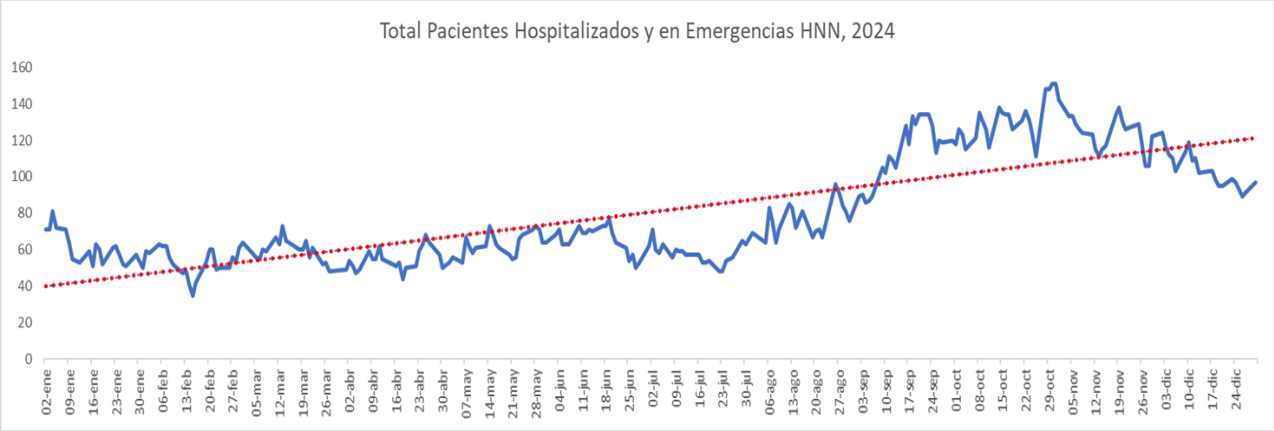
Gráfico 15.
Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 52 en Costa Rica, 2024.



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2024.

En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 52 del año 2024 es la siguiente:
Al 28 de diciembre del año en curso, correspondiente a la semana 52, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 97, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 136%; sin embargo, los datos reportados el día de hoy en el HNN indican lo siguiente: 76 pacientes hospitalizados con una ocupación del 113%.

Gráfico 16.
Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 51 del año 2024, Hospital Nacional de Niños.



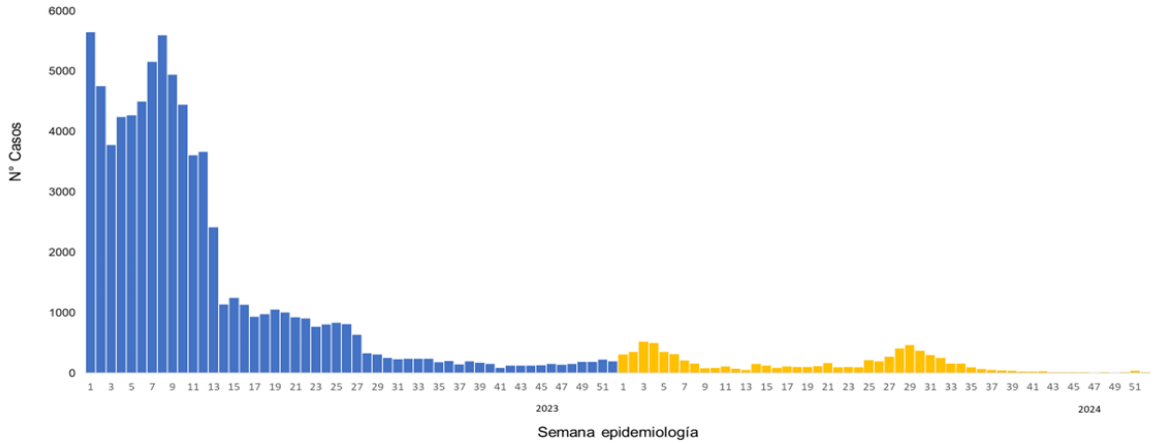
Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2024.

Como observaciones finales se puede indicar lo siguiente:

- IRAG con 11749 casos a la semana 52.
- IRAS con 1382004 casos a la semana 52.
- ETI con 22241 casos reportados a la semana 52.
- Actualmente, la ocupación de camas respiratorias en el HNN es de un 113% (hay 76 pacientes con patologías respiratorias).
- En SE-52, el Rinovirus es el virus que más ha circulado, seguido del Virus Sincicial Respiratorio y en tercer lugar circula el virus de influenza estacional.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 52 (que abarca del 22 al 28 de diciembre del 2024), se reportaron un total de 14 casos confirmados, lo que representa una disminución del 61.11% con respecto a la SE-51 del año 2024.

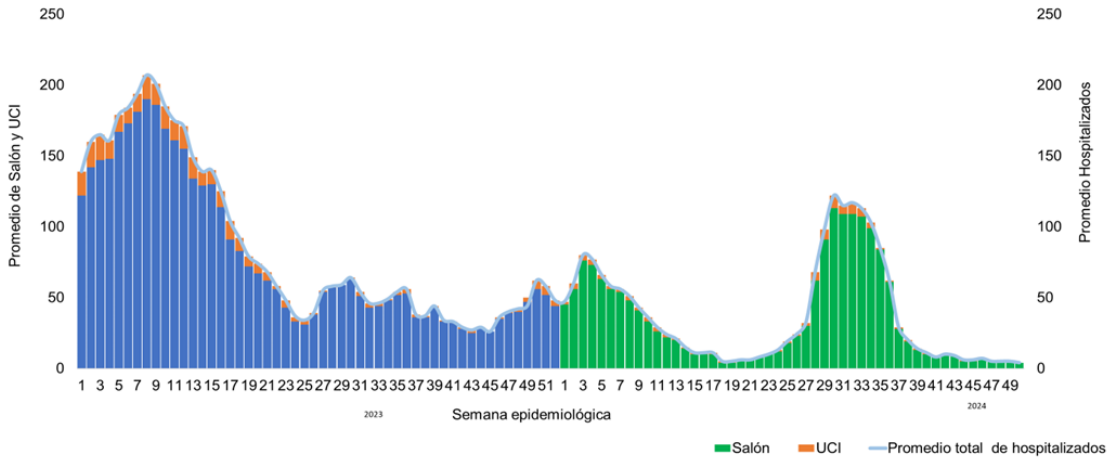
Gráfico 17.
Costa Rica: Casos COVID-19, según semana epidemiológica año 2023-2024.



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS/Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2024.Datos sujetos para actualizar

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 52, se reportó un promedio total de 3 hospitalizados, lo que representa una disminución del 40% respecto a la SE-49 del año 2024.

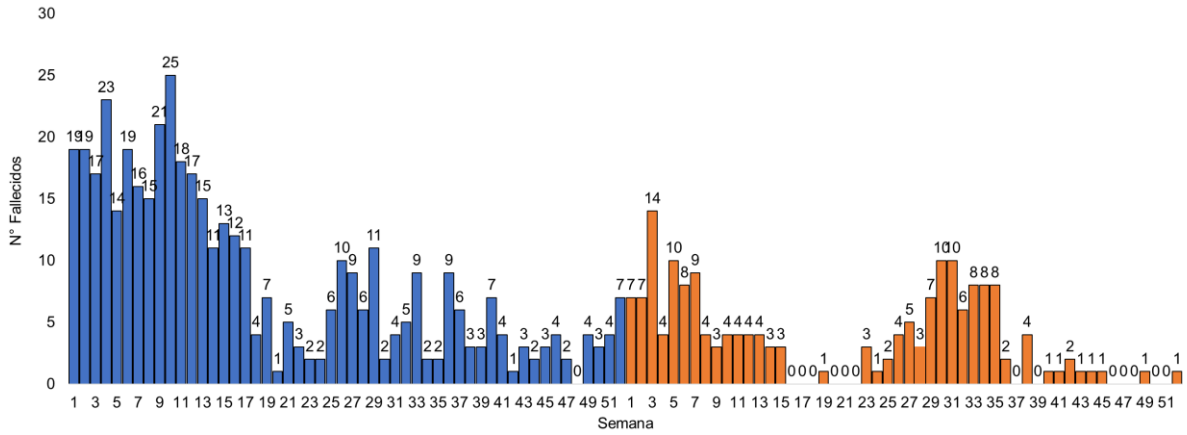
Gráfico 18.
Costa Rica: Promedio total de hospitalizados en salón y Unidad de Cuidados Intensivos, según reporte semanal año 2023-2024.



Fuente: Área de Estadística en Salud, CCSS/Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2023-2024.

En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 52, no hubo fallecidos; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.

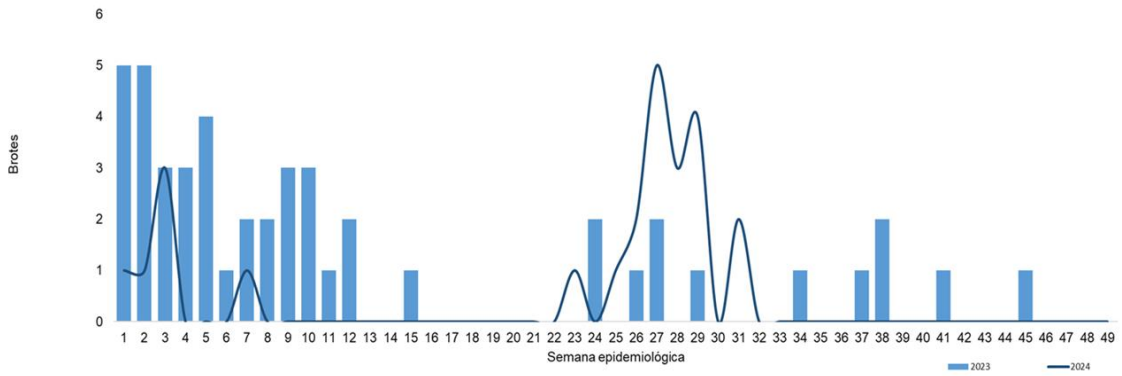
Gráfico 19.
Costa Rica: Personas fallecidas asociadas a COVID-19, según reporte semanal año 2023-2024.



Fuente: Área de Estadística en Salud, C.C.S.S. / Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2024.

Para la semana epidemiológica 52 no se reportaron brotes asociados a COVID-19.

Gráfico 20.
Brotes de covid-19, por semana epidemiológica en Costa Rica, 2024.

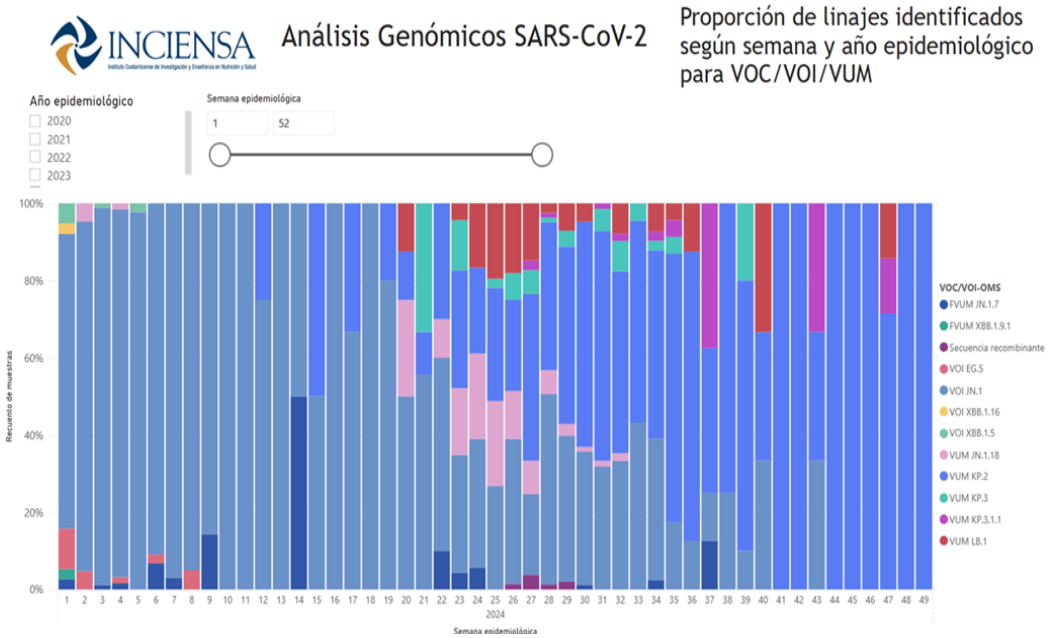


Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, 2024.

Variantes genómicas

Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 12 de enero del 2025, se reporta lo siguiente según lo indicado. (Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, 2024).

Gráfico 21.
Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 1 a 49 del 2024.



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 12 de enero del 2025.

En relación con la proporción relativa de sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo comprendido entre las SE-1 y 49 del año 2024, se tiene la siguiente información.

Cuadro 1.
Costa Rica: Proporción relativa de Sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el período de las semanas epidemiológicas 1 a 49 de 2024

Linaje Pangolin	Cantidad	%
LB.1	65	5.14
EG.5	10	0.79
XBB.1.16	1	0.08
JN.1*	679	53.68
XBB.1.5.	4	0.32
XBB.1.9.1	1	0.08
JN.1.7	16	1.26
KP.2	379	29.96
KP.3	36	2.85
KP.3.1.1	12	0.95
Secuencia recombinante	7	0.55
JN.1.18	55	4.35
Total	1265	100.00

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 14 de enero 2025.

Bibliografía

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. (2025). Informe Interactivo de Vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2 semana 22. San José: INCIENSA. Obtenido de https://inciensa.sa.cr/Vigilancia%20genomica%20SARS-CoV-2.aspx

Intoxicación por metanol

Datos al 16 de enero del 2025

Ted Alpízar Calvo
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

La intoxicación por metanol un alcohol tóxico, no apto para bebidas es una de las patologías de más alta mortalidad en urgencias. Al ser una patología no común y con síntomas y signos no específicos muchas veces la pasamos por alto y con esto aumentamos su mortalidad. Este es uno de los padecimientos que ante la alta sospecha en la historia clínica y sintomatología debemos abordar de inmediato con el fin de evitar un desenlace fatal. Sus síntomas se deben principalmente al acúmulo de ácido fórmico que causa alteraciones pulmonares, metabólicas, neurológicas y renales. Es un padecimiento el cual debe notificarse una vez confirmado el diagnóstico con el fin de realizar un barrido y encontrar los causantes, antes de evitar brotes mayores.

El Decreto de Vigilancia de la Salud N° 40556-S, indica que la intoxicación con metanol es de notificación obligatoria al Ministerio de Salud debido a su impacto en la salud pública; ya que puede causar un cuadro grave de intoxicación, discapacidad en la persona e inclusive la muerte, si no se trata oportunamente. Por este motivo, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son cruciales para mejorar el pronóstico.

El Ministerio de Salud de Costa Rica haciendo uso de sus potestades, que le confiere la legislación, establece los lineamientos que deben seguir los establecimientos de salud públicos y privados, cuando se presenten casos de intoxicación con metanol. Se pretende con los lineamientos orientar al personal de salud, en los procedimientos a seguir para evitar las discapacidades y la mortalidad que podrían producir este tipo de intoxicación.

Datos

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos vivos y casos fallecidos, sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro, indicador seleccionado por sexo. Del 1 de enero al 16 de enero 2025.

Indicador	**Sexo biológico notificado**		
Morbilidad	**Mujeres**	**Hombres**	**Total**
Número de casos (vivos)	0	0	0
Porcentaje (%) del total	0	0	0
Rango edad (años)	0	0	0
Promedio edad (años)	0	0	0
Edad desconocida	0	0	0
Mortalidad			
Número de casos (fallecidos)	1	1	1
Porcentaje (%) del total	100 %	0	0
Rango edad (años)	48	0	0
Promedio de edad (años)	48	0	0
Edad desconocida	0	0	0
Total (número de vivos y fallecidos)	1	0	0

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Cuadro 2.
Costa Rica: Casos vivos y casos fallecidos, sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro, por provincia, cantón y condición de egreso. Del 1 de enero al 16 de enero 2025

Provincia	**Cantón**	**Condición de egreso**		**Total**
		Fallecidos	**Vivos**	
San José	San José	1		1
Total (2025)		1		1

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Cuadro 3.
Costa Rica: Casos vivos y casos fallecidos, sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro por grupos de edad y por condición egreso. Del 1 de enero al 16 de enero 2025

Grupos de edad (años)	Condición de egreso		Total
	Fallecido	Vivo	
20-29			
30-39			
40-49	1		1
50-59			
60-69			
70 y mas			
Desconocido			
Total			1

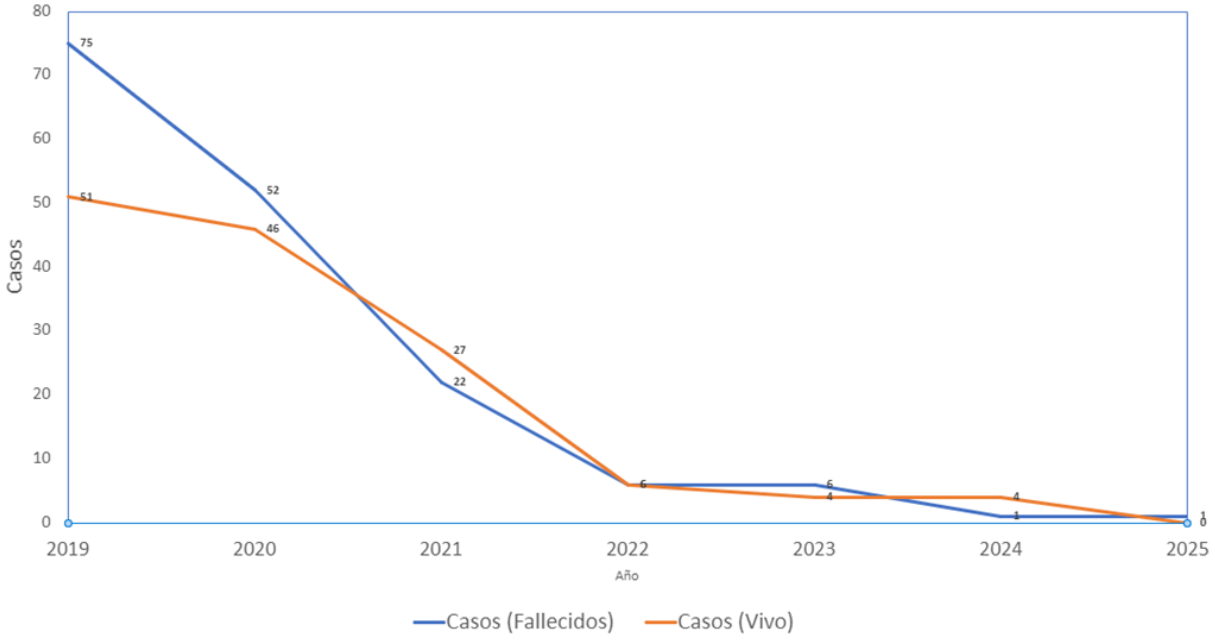
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Cuadro 4.
Costa Rica: Casos vivos y casos fallecidos, sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro por condición y año de ocurrencia. Del 1 de enero al 16 de enero 2025

Condición	Año de ocurrencia							Total
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Casos (Fallecidos)	75	52	22	6	6	2	1	164
Casos (Vivo)	51	46	27	6	4	4	0	138
Total (2019-2024)	**126**	**98**	**49**	**12**	**10**	**6**	**1**	**302**

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Gráfico 1.
Curva de casos vivos y casos fallecidos, sospechosos por intoxicación por Metanol según fecha de registro por condición y año de ocurrencia



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Infecciones de transmisión sexual

Pamela Domínguez Saavedra
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Stephany Alvarado Garita
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

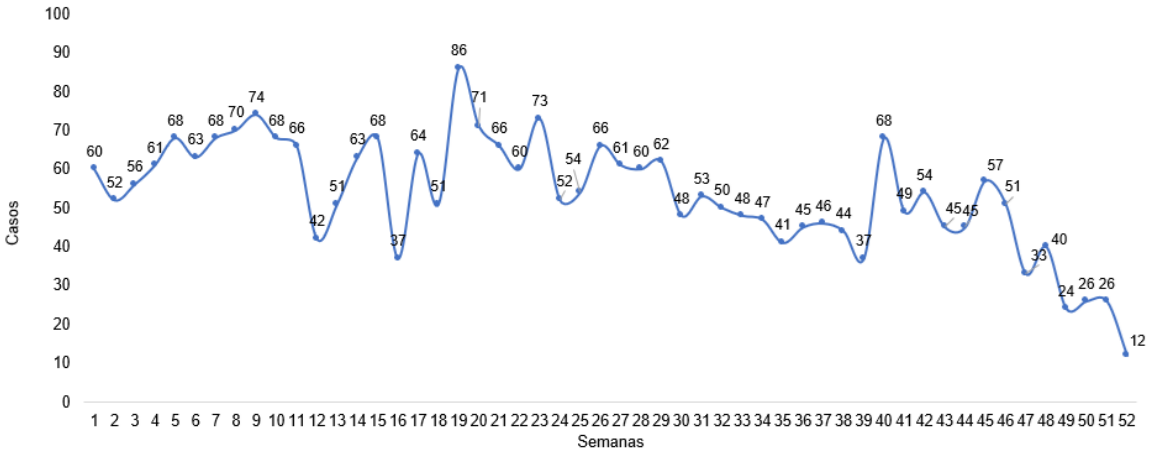
Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

En la vigilancia de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se presenta un informe preliminar en Sífilis en todas sus formas, Gonorrea, Herpes Virus y Virus del Papiloma Humano durante las semanas 1 al 52 del año 2024.

Sífilis en Todas sus Formas

Es una enfermedad de transmisión sexual que es causada por una espiroqueta llamada *Treponema pallidum*, exclusiva del ser humano. Puede generar un problema de salud pública e incluso puede provocar el fallecimiento en algunas personas. Sífilis en todas sus formas ha presentado el siguiente comportamiento epidemiológico en el cierre preliminar del año 2024, con un reporte total de 2 782 casos con una tasa de 52,40 por 100 000 habitantes, en el mismo periodo del año 2023 se reportaron 2 280 casos con una tasa de 43,30 por 100 000 habitantes, lo que representa para el año 2024 un incremento de 22,0% con 502 casos. En el gráfico 1, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por Sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte del año 2024



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de Sífilis en todas sus formas, en el año 2024, se han reportado en hombres un 60,14% de los casos (1673/2782), con una tasa de 62,6 por 100 000 habitantes, el comportamiento en las mujeres se presentó con el 39,86% de los casos (1109/2782) con una tasa de 42,0 por 100 000 habitantes.

En el cuadro 1, se muestran los casos, según grupos de edad observándose que el de 20 a 64 años presenta más casos con 83,25% (2316/2782), seguidos por los mayores de 65 años (240/2782), luego el grupo de 15 a 19 años (123/2782), los menores de 1 año y de 1 a 14 años reportaron 103 casos.

Cuadro 1
Costa Rica: Casos confirmados por Sífilis en todas sus formas, según grupos de edad quinquenal, número absoluto y tasas. Tasa por 100,000 habitantes, año 2024

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	95	139,3
de 1 a 4 años	5	1,8
de 5 a 9 años	1	0,3
de 10 a 14 años	2	0,5
de 15 a 19 años	123	32,6
de 20 a 24 años	361	90,9
de 25 a 29 años	465	108,6
de 30 a 34 años	390	87,1
de 35 a 39 años	297	65,8
de 40 a 44 años	232	58,9
de 45 a 49 años	178	53,3
de 50 a 54 años	151	52,1
de 55 a 59 años	121	43,2
de 60 a 64 años	121	47,1
de 65 a 69 años	79	38,5
de 70 a 74 años	68	46,6
75 años y más	93	46,3
Total	2782	52,40

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS/Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 2, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias y en el cuadro 3, por las nueve regiones del país.

Cuadro 2
Costa Rica: Casos confirmados por Sífilis en todas sus formas, según provincias. Número absoluto y tasas. Tasa por 100,000 habitantes, año 2024

Provincias	Nº	Tasa
San José	1035	60,6
Alajuela	380	35,2
Cartago	277	50,0
Heredia	298	53,9
Guanacaste	119	28,7
Puntarenas	244	46,8
Limón	429	89,5
Total	2782	52,40

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos confirmados por Sífilis en todas sus formas, según región. Número absoluto y tasas. Tasa por 100,000 habitantes, año 2024

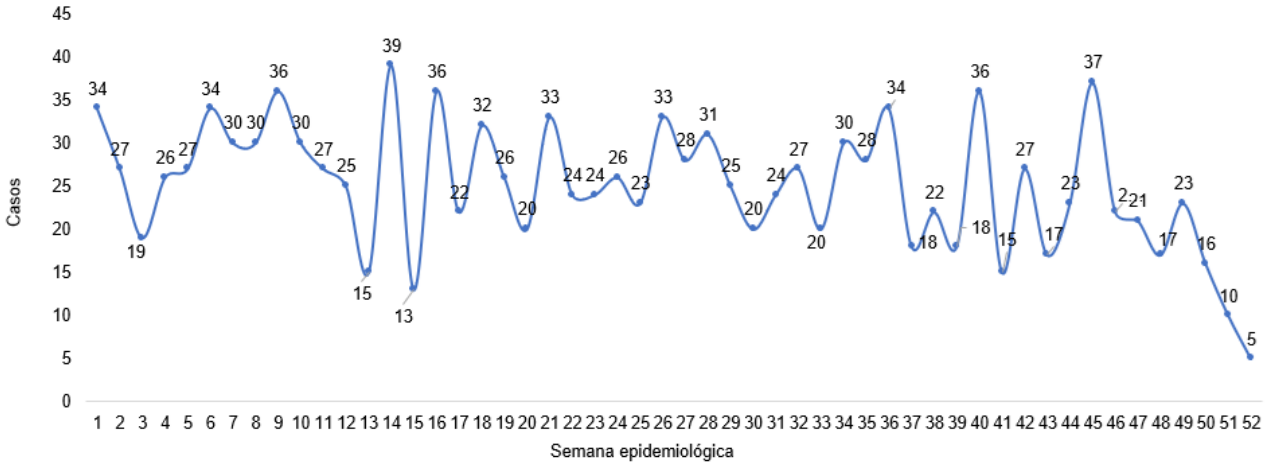
Regiones	Casos	Tasa
Brunca	128	33,9
Central Este	279	48,5
Central Norte	517	49,4
Central Sur	997	64,7
Chorotega	127	26,9
Huetar Caribe	429	89,5
Huetar Norte	59	22,0
Central Occidente	84	36,7
Pacífico Central	162	50,5
Total	2782	52,40

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Gonorrea

En el año 2024, se han notificado 1 305 casos con una tasa de 24,60 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2023 se reportaron 885 casos con una tasa de 17 por 100 000 habitantes, lo que representa para el año 2024, un incremento del 47,45% con 420 casos. El gráfico 2, muestra el comportamiento según reporte semanal.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados por Gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en el año 2024



Nota: Los datos sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Para el año 2024, se presentó un predominio en los hombres con el 88,66% (1157/1305), con una tasa de 43,3 por 100 000 habitantes. En las mujeres se reportaron con 11,34% (148/1305) con una tasa de 5,6 por 100 000 habitantes.

En el cuadro 4, se presentan los casos por grupos de edad, siendo el reporte en el grupo de 20 a 64 años con mayor cantidad de casos reportados con 84,96% (1104/1305). Luego el grupo de 15 a 19 años con un 11,49% (150/1305), seguido por el grupo de mayores de 65 años con 2,68% (35/1305), y 16 casos en los grupos de menores de 1 año y 1 a 14 años.

Cuadro 4
Costa Rica: Casos notificados por Gonorrea, según grupos de edad quinquenal. Número absoluto y tasas. Tasa por 100,000 habitantes, año 2024

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	4	5,9
1 a 4	3	1,1
5 a 9	3	0,8
10 a 14	6	1,6
15 a 19	150	39,7
20 a 24	336	84,6
25 a 29	244	57,0
30 a 34	181	40,4
35 a 39	142	31,5
40 a 44	79	20,1
45 a 49	41	12,3
50 a 54	29	10,0
55 a 59	34	12,1
60 a 64	18	7,0
65 a 69	17	8,3
70 a 74	11	7,5
Más 75 años	7	3,5
Total	1305	24,60

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 5, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las provincias y en el cuadro 6, en las nueve regiones del país.

Cuadro 5
Costa Rica: Casos notificados por Gonorrea, según provincias. Número absoluto y tasas. Tasa por 100,000 habitantes, año 2024

Provincias	Casos	Tasa
San José	532	31,2
Alajuela	168	15,5
Cartago	105	19,0
Heredia	149	27,0
Guanacaste	46	11,1
Puntarenas	163	31,2
Limón	142	29,6
Total	1305	24,60

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Cuadro 6
Costa Rica: Casos notificados por Gonorrea, según región. Número absoluto y tasas. Tasa por 100,000 habitantes, año 2024

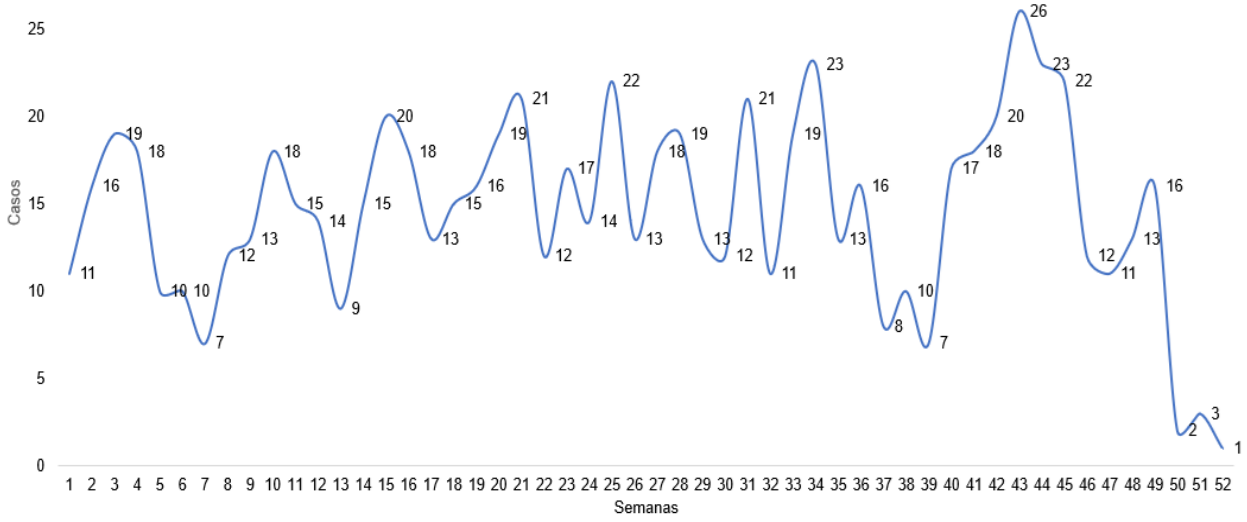
Regiones	Casos	Tasas
Brunca	96	25,5
Central Este	104	18,1
Central Norte	236	22,6
Central Sur	492	31,9
Chorotega	55	11,7
Huetar Caribe	142	29,6
Huetar Norte	25	9,3
Central Occidente	40	17,5
Pacífico Central	115	35,9
Total	1305	24,60

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Herpes Virus

El Herpes Virus es otra de las Infección de transmisión sexual, que fue reportada en el año 2024, con 761 casos con una tasa de 14,30 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2023 se reportaron 561 casos con una tasa de 10,7 por 100 000 habitantes, lo que representa para el año 2024, un incremento de 35,65% con 200 casos. El gráfico 3, presenta el comportamiento según reporte semanal.

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados por Herpes virus, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en año 2024



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del Herpes Virus, en el año 2024, presenta unpredominio en las mujeres con el 61,24% (466/761) con una tasa de 17,7 por 100 000 habitantes, en los hombres se presenta con 38,76% (295/761) con una tasa de 11,0 por 100 000 habitantes.

En el cuadro 7, se presentan los casos por grupos de edad, siendo los adultos de 20 a 64 años con mayor cantidad de casos con un 81,34%(619/761), seguidos por el grupo de 15 a 19 años 11,96% (91/761), luego los mayores de 65 año con 4,73% (36/761), y finalmente por los grupo de menores de 1 año y de 1 a 14 años con 15 casos.

Cuadro 7
Costa Rica: Casos notificados por Herpes Virus, según grupos de edad quinquenal, número absoluto y tasas.Tasa por 100,000 habitantes, año 2024

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	0	0,0
5 a 9	2	0,5
10 a 14	12	3,2
15 a 19	91	24,1
20 a 24	144	36,3
25 a 29	114	26,6
30 a 34	108	24,1
35 a 39	77	17,1
40 a 44	46	11,7
45 a 49	40	12,0
50 a 54	42	14,5
55 a 59	29	10,4
60 a 64	19	7,4
65 a 69	22	10,7
70 a 74	5	3,4
Más 75 años	9	4,5
Total	761	14,30

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 8, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las provincias y en el cuadro 9, en las nueves regiones del país.

Cuadro 8
Costa Rica: Casos notificados de Herpes Virus según provincia, números absolutos y tasas.
(Tasa p/100,000 habitantes), año 2024

Provincias	Casos	Tasa
San José	302	17,7
Alajuela	147	13,60
Cartago	63	11,38
Heredia	62	11,22
Guanacaste	14	3,37
Puntarenas	87	16,7
Limón	86	17,95
Total	761	14,30

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Cuadro 9
Costa Rica: Casos notificados de Herpes Virus según región, números absolutos y tasas.
(Tasa p/100,000 habitantes), año 2024

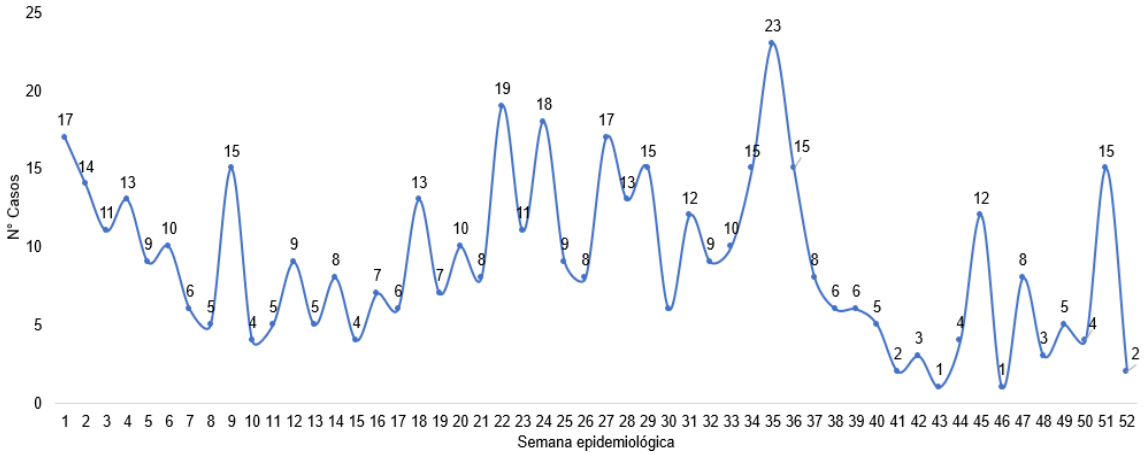
Regiones	Casos	Tasa
Brunca	67	17,8
Central Este	63	11,0
Central Norte	132	12,6
Central Sur	268	17,4
Chorotega	29	6,1
Huetar Caribe	86	18,0
Huetar Norte	34	12,7
Central Occidente	23	10,1
Pacífico Central	59	18,4
Total	761	14,30

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

El VPH en el año 2024, se notificaron 471 casos con una tasa de 8,90 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2023 se reportaron 195 casos con una tasa de 3,7 por 100 000 habitantes, lo que representa para el año 2024 un incremento del 141,53% con de 276 casos. El gráfico 4 presenta el comportamiento según reporte semanal.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humano, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, año 2024



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados.
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, 2025.

En el año 2024 el VPH, presentó un predominio en las mujeres con el 80,47% (379/471) con una tasa de 14,37 por 100 000 habitantes, los hombres con 19,53% (92/471) con una tasa de 3,44 por 100 000 habitantes.

En el cuadro 10, se presentan los casos por grupos de edad, siendo los adultos de 20 a 64 años con mayor cantidad de casos con 96,60% (455/471), seguidos por el grupo de 15 a 19 años con 2,12% (10/471), el grupo de mayores de 65 años (5/471) y los menores de edad 10 a 14 años con 1 caso reportado.

Cuadro 10.
Costa Rica: casos notificados por Virus del Papiloma Humano, según grupos de edad quinquenal. Número absoluto y tasas por 100,000 habitantes, año 2024

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	0	0,0
de 1 a 4 años	0	0,0
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	1	0,3
de 15 a 19 años	10	2,6
de 20 a 24 años	54	13,6
de 25 a 29 años	59	13,8
de 30 a 34 años	98	21,9
de 35 a 39 años	61	13,5
de 40 a 44 años	56	14,2
de 45 a 49 años	49	14,7
de 50 a 54 años	47	16,2
de 55 a 59 años	18	6,4
de 60 a 64 años	13	5,1
de 65 a 69 años	5	2,4
de 70 a 74 años	0	0,0
75 años y más	0	0,0
Total	471	8,90

Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados.
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, 2025.

En el cuadro 11, se presenta el comportamiento de la enfermedad Virus del Papiloma Humano, según provincia y el cuadro 12, según las nueve regiones del país.

Cuadro 11
Costa Rica: Casos notificados de Virus del papiloma Humano, según provincias en números absolutos y tasas (Tasa p/100,000 habitantes), año 2024

Provincias	Nº	Tasa
San José	106	6,2
Alajuela	20	1,9
Cartago	13	2,3
Heredia	27	4,9
Guanacaste	119	28,7
Puntarenas	18	3,4
Limón	168	35,1
Total	471	8,90

Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados.
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, 2025.

Cuadro12.
Costa Rica: Casos notificados de Virus del papiloma Humano, según región en números absolutos y tasas (Tasa p/100,000 habitantes), año 2024

Regiones	Casos	Tasas
Brunca	4	1,1
Central Este	12	2
Central Norte	33	3,2
Central Sur	107	6,9
Chorotega	119	25,2
Huetar Caribe	168	35,1
Huetar Norte	1	0,4
Central Occidente	5	2,2
Pacífico Central	22	6,9
Total	471	8,90

Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados.
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, 2025.

Costa Rica: información sobre los femicidios

(actualizada al 12/12/2024)

Gloriela Brenes Murillo
Unidad de Epidemiología
Dirección Vigilancia de la Salud

Siany Cordero Abarca
Unidad Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección Vigilancia de la Salud

Enero, 2025

Introducción

El femicidio es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Este crimen se enmarca dentro de la violencia de género y es una de sus expresiones más extremas. Los femicidios suelen ocurrir en contextos donde las mujeres son sometidas a tratos vejatorios, crueles o dolorosos debido a su género.

El término fue popularizado por la activista feminista Diana Russell, quien lo definió como "***el asesinato de mujeres motivado por odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia ellas".*** Este tipo de violencia refleja una profunda desigualdad de género y es una manifestación extrema del machismo y la cultura de la violación.

A nivel mundial, los femicidios son una trágica realidad. En 2023, aproximadamente 51,100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas u otros familiares. Esto equivale a que, en promedio, 140 mujeres o niñas murieron cada día a manos de alguien de su propia familia. Este tipo de violencia refleja profundas desigualdades de género y es una manifestación extrema de la violencia contra las mujeres

Principales causas

Misoginia: El odio hacia las mujeres es una de las causas fundamentales. Este odio puede manifestarse en actitudes y comportamientos que desprecian y deshumanizan a las mujeres.

Sentimiento de superioridad: Algunos hombres creen que son superiores a las mujeres y que tienen derecho a controlarlas o castigarlas.

Celos y posesividad: En relaciones íntimas, los celos extremos y la creencia de que la pareja es una propiedad pueden llevar a actos de violencia extrema.

Cultura de la violencia: En sociedades donde la violencia es una forma común de resolver conflictos, los femicidios pueden ser más frecuentes.
Factores socioeconómicos: La pobreza, la falta de educación y el acceso limitado a recursos pueden exacerbar las tensiones y contribuir a la violencia de género.
Estos factores no actúan de manera aislada, sino que a menudo se combinan y refuerzan mutuamente, creando un entorno en el que la violencia contra las mujeres se da.

Medidas integrales y coordinadas de prevención de femicidios

Educación y sensibilización: Promover la igualdad de género y educar a la sociedad sobre la violencia de género desde una edad temprana puede ayudar a cambiar actitudes y comportamientos.
Fortalecimiento de leyes y políticas: Implementar y hacer cumplir leyes que protejan a las mujeres y castiguen severamente la violencia de género es crucial.
Apoyo a las víctimas: Proveer recursos y servicios de apoyo, como refugios, líneas de ayuda y asesoramiento psicológico, puede ayudar a las mujeres en riesgo.
Capacitación de autoridades: Entrenar a la policía, jueces y otros funcionarios en la identificación y manejo de casos de violencia de género con una perspectiva de género.
Campañas de concienciación: Realizar campañas públicas para aumentar la conciencia sobre los signos de abuso y cómo intervenir de manera segura.
Estas acciones, combinadas con un compromiso social y político fuerte, pueden contribuir significativamente a la prevención de los femicidios.

Femicidios, problema de salud pública

Impacto en la salud física y mental: Los femicidios no solo resultan en la pérdida de vidas, sino que también afectan profundamente la salud mental y emocional de las familias y comunidades. El trauma y el miedo generados pueden tener efectos duraderos.
Visibilización del problema: Al tratar los femicidios como un problema de salud pública, se reconoce la magnitud y la gravedad del problema, lo que puede llevar a una mayor atención y recursos para abordarlo.
Prevención y educación: Enmarcar los femicidios como un problema de salud pública permite implementar programas de prevención y educación que pueden ayudar a cambiar actitudes y comportamientos hacia la violencia de género.
Políticas y recursos: Este reconocimiento puede impulsar la creación de políticas públicas más efectivas y la asignación de recursos necesarios para apoyar a las víctimas y prevenir futuros casos.

Enfoque integral: Abordar los femicidios desde una perspectiva de salud pública permite un enfoque más integral que incluye la justicia, la salud, la educación y el bienestar social

En resumen, reconocer los femicidios como un problema de salud pública es esencial para desarrollar estrategias efectivas de prevención y apoyo, y para movilizar a la sociedad en la lucha contra la violencia de género.

Costa Rica, femicidios

En Costa Rica, el femicidio está tipificado en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVcM), promulgada en el año 2007 y con reformas importantes en el año 2021. El último informe oficial del Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación del Poder Judicial sobre femicidio responde al oficio N° 138-2024, y fue conocido por el Consejo Superior, en su sesión del 11 de enero de 2024.

Tipos de femicidios:

Los datos estadísticos contemplan tres tipos de femicidio. **El primero es el femicidio**, tipificado por el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres (LPVcM), el cual, hasta el 9 de junio de 2021 sancionaba sólo las muertes de las mujeres a manos de sus cónyuges o parejas actuales, y por interpretación jurisprudencial, excepcionalmente se incluían algunos casos a manos de expareja. Por reforma a dicha ley, a partir del 10 de junio del mismo año, el mencionado artículo incluye los asesinatos de mujeres en los siguientes escenarios: las relaciones de noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor.

El segundo tipo de femicidio que se contabiliza en Costa Rica es el femicidio ampliado. Esta es una construcción estadística que tiene por fin visibilizar aquellas muertes de mujeres, también por razones de género, pero que no están contempladas en los supuestos del artículo 21 de la LPVcM y durante muchos años, su único sustento normativo fue el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como "Convención de Belém do Pará "(1994).

El tercer tipo de femicidio, Femicidio en otros contextos, fue establecido mediante la inclusión del artículo 21bis de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, y se aplicará para las muertes ocurridas después del 23 de agosto de 2021.

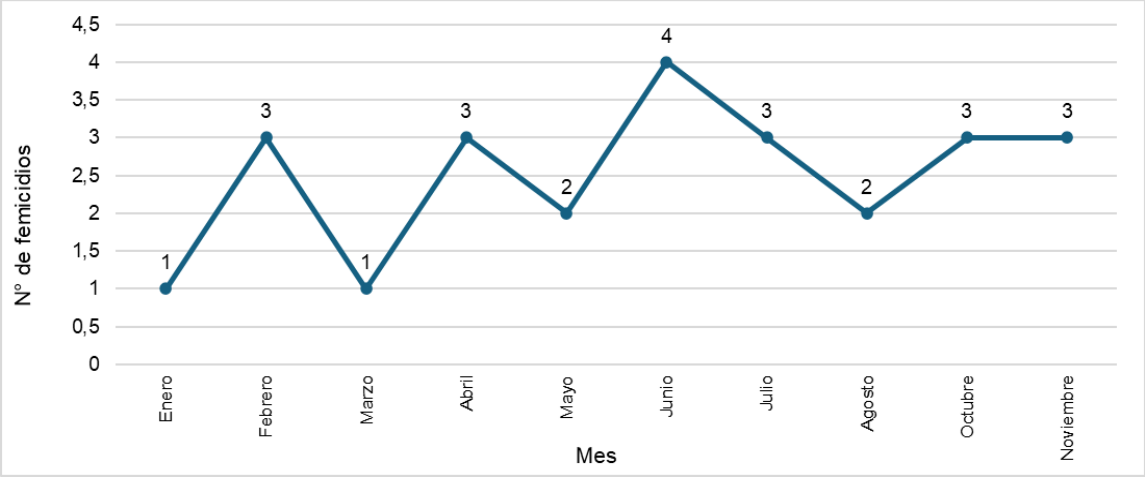
En ella se contemplan la mayoría de los escenarios que histórica y estadísticamente hasta entonces se habían considerado como supuestos del femicidio ampliado y, además, se agregan nuevos escenarios. Se establecen penas de hasta 35 años de prisión, para aquellos casos en los que la persona autora se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza, amistad, de parentesco, de autoridad o de una relación de poder que tuviera con la mujer víctima o bien, cuando el hecho hubiera ocurrido dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado; sea que vivieran o no bajo el mismo techo. Estos eran escenarios del femicidio ampliado, que habían quedado por fuera en la reforma del 10 de junio de 2021.

Información estadística de femicidios en Costa Rica, actualizada al 12 de diciembre 2024

Al 12/12/2024, según datos del Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, habían ocurrido 76 muertes violentas de mujeres, de las cuales *25 muertes habían sido clasificadas como femicidios*, 15 homicidios no femicidios y 36 estaban pendientes de clasificar por parte de la *Subcomisión Interinstitucional de Prevención de Femicidios*, esto debido a que la Fiscalía de Género no había tenido ninguna información derivada de la investigación o bien la oportunidad de acceder a la misma, ni siquiera de carácter preliminar

Con respecto a los meses de ocurrencia, el gráfico 1, evidencia que junio fue el mes con más femicidios durante el 2024, seguido de los meses de febrero, abril y octubre, en el mes que no hubo femicidios fue setiembre.

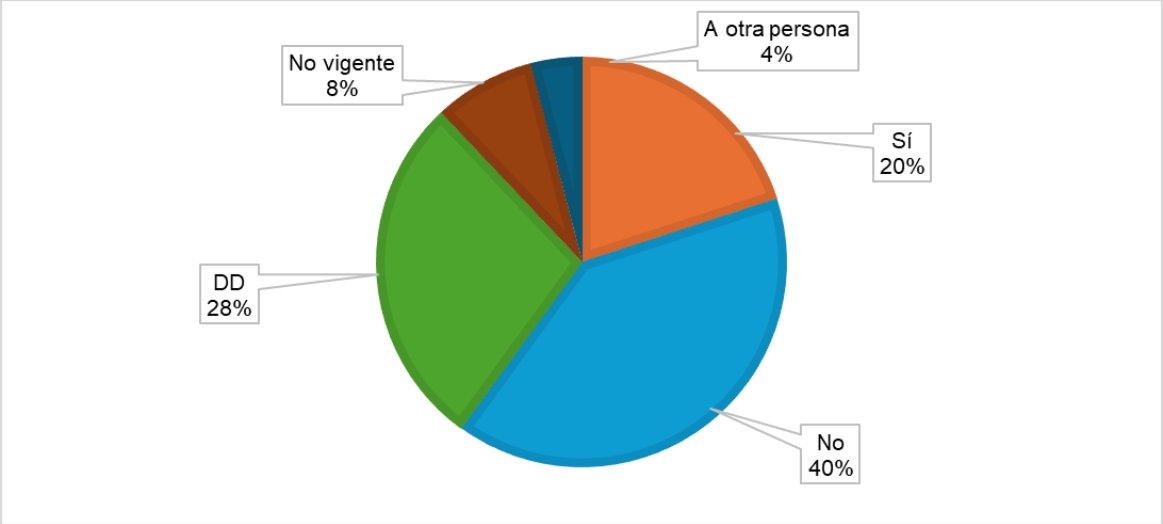
Gráfico 1.
Costa Rica: número de femicidios según mes de ocurrencia, 2024



Fuente: Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia

El gráfico 2, indica que en el mayor porcentaje de los femicidios las víctimas no habían solicitado las medidas de protección, lo cual contrasta con el porcentaje de las que si la habían solicitado, que es un porcentaje mucho menor y e incluso es más alto el porcentaje en donde el dato se desconoce en cuanto a si la víctima había o no solicitado medidas de protección.

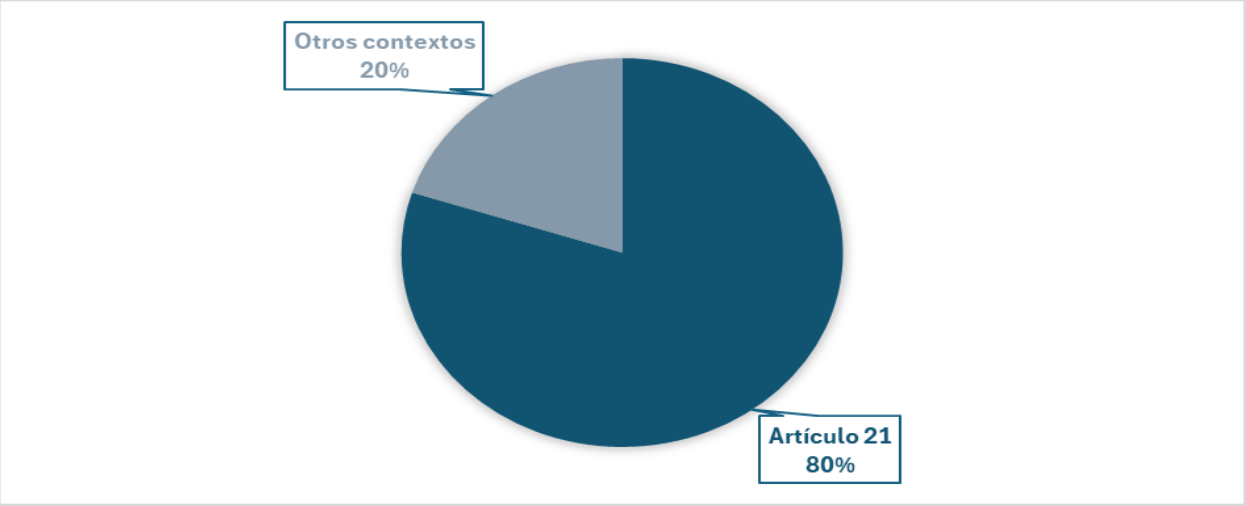
Gráfico 2.
Costa Rica: porcentaje de medidas de protección de las víctimas al momento del femicidio



Fuente: Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia

El siguiente gráfico indica el mayor porcentaje de femicidios con base en la categorización que realiza la Subcomisión Interinstitucional de Prevención de Femicidios, en este sentido el porcentaje más alto corresponde a los casos tipificados según Artículo 21 de la LPVCM que incluye entre otros los siguientes escenarios*: relaciones de noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura, así mismo el porcentaje más bajo corresponde a los casos tipificados como femicidios en otros contextos es decir para aquellos casos en los que la persona autora se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza, amistad, de parentesco, de autoridad o de una relación de poder que tuviera con la mujer víctima o bien, cuando el hecho hubiera ocurrido dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado; sea que vivieran o no bajo el mismo techo*. Para el momento de la actualización no había casos según el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como "Convención de Belém do Pará "(1994).

Gráfico 3.
Costa Rica: porcentaje de femicidios según categorías, 2024



Fuente: Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia

Con relación a los grupos de edad de las mujeres víctimas de femicidio las que estaban en edades entre los 30-34 años representaron la mayor cantidad de casos lo que equivale a un 28% del total de casos según los grupos de edad, les siguen las del grupo entre los 45-49 que representa un 16% y en una tercera posición las que se encontraban con edades entre los 40-44 que implicar un 12% del total de casos. Lamentablemente la mayoría de los grupos de edad están representados, desde una menor de edad hasta una adulta mayor.

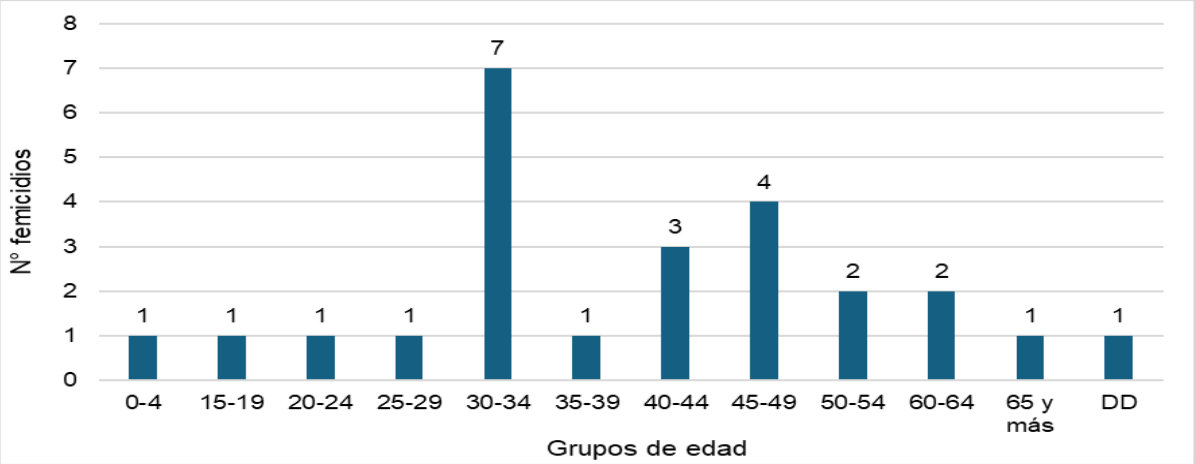
Es importante reconocer que los grupos de edad con la mayor cantidad de casos eran madres, estudiantes, trabajadoras, personas que iniciaban sus planes de vida, con sueños e ilusiones que se vieron truncados a manos de sus femicidas.

Si bien es cierto las características psicosociales y económicas de las mujeres entre 30 y 34 años pueden variar ampliamente según el contexto cultural, geográfico y socioeconómico, sin embargo hay aspectos que son propios de estos grupos de edad, en el caso de las mujeres fallecidas por femicidio es posible que estuvieran establecidas en sus carreras y/o proyectos de vida, buscando avanzar en sus propósitos, algunas eras madres por lo que tenían sueños e ilusiones con sus hijos e hijas, equilibrando esas responsabilidades laborales y familiares, porque es posible que además fueran jefas de hogar.

Además de ser mamás, eran hijas, hermanas, tías, primas, amigas, abuelas, etc., quizá con redes de apoyo social importantes, y con conexiones significativas con amigos y familiares que dejaron de ser de forma abrupta y dolorosa.

Finalmente, quizá algunas de ellas tenían ingresos estables, o estudiaban para cumplir con sus proyectos de vida, para la educación de hijos e hijas, o compra de bienes o de apoyo etc.

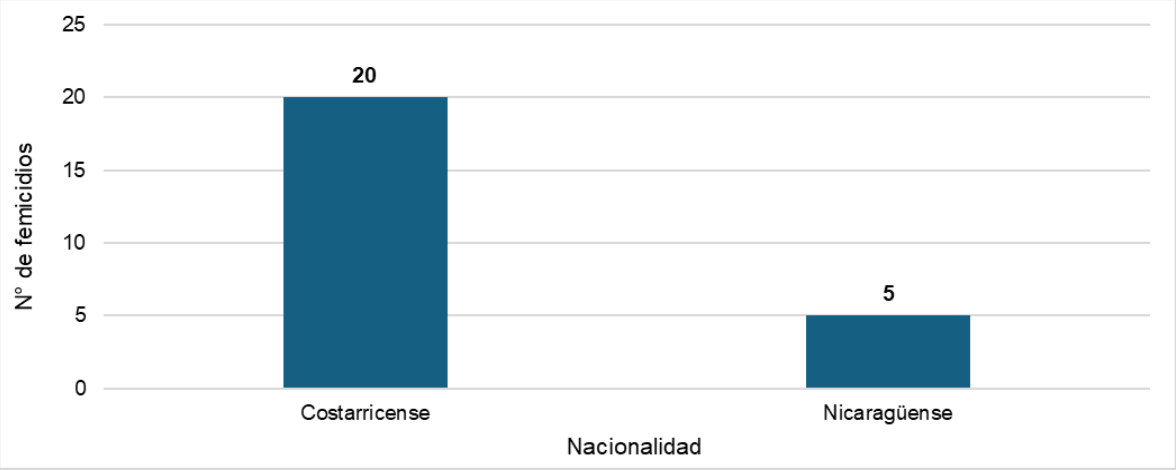
Gráfico 4.
Costa Rica: casos de femicidios según edad de la víctima, 2024



DD: Dato Desconocido
Fuente: Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia

Como está claro en el gráfico 5 la mayor cantidad de femicidios afectaron a mujeres costarricenses lo cual representa un 80% del total de femicidios al 12 de diciembre, el otro 20% corresponde a mujeres nicaragüenses.

Gráfico 5.
Costa Rica: casos de femicidios según nacionalidad de la víctima, 2024



Fuente: Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia

En cuanto a la distribución según las provincias, el mapa 1, indica que Puntarenas tiene la mayor cantidad de casos, le sigue San José en una segunda posición y en tercer lugar la provincia de Alajuela. Cabe destacar que Puntarenas es la provincia con más homicidios en lo que va del año por diversas causas, además en términos de notificación de casos de violencia intrafamiliar también tiene la tasa más alta.
Son diversos los factores interrelacionados que mantienen altos niveles de violencia que crean un entorno propicio para la violencia y dificultan los esfuerzos de las autoridades para mantener la seguridad en este lugar, algunos elementos son:

Narcotráfico: La provincia es utilizada como punto de entrada y almacenamiento de drogas, lo que genera conflictos entre bandas por el control del territorio.
Falta de empleo: La escasez de oportunidades laborales lleva a algunos residentes a involucrarse en actividades delictivas como medio de subsistencia.
Deserción escolar: Muchos jóvenes abandonan la escuela y se convierten en presa fácil para las bandas criminales.
Reincidencia delictiva: Algunos delincuentes reinciden en actividades criminales tras cumplir penas de prisión preventiva.

Mapa 1.
Costa Rica: casos de femicidios según provincia de ocurrencia, 2024



Fuente: Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia

La siguiente tabla evidencia el comportamiento de los femicidios según los cantones principales por provincia, al respecto San José, la capital posee la densidad más alta de población por lo que han sucedido femicidios en 6 cantones distintos de esta provincia, por otro lado en los cantones de Alajuela sucede una situación similar y también en la provincia de Cartago, en donde el cantón de Paraíso reporta un femicidio, en relación con los cantones de Heredia, dos tienen femicidios, igual que en los cantones de Guanacaste de “tradición” con casos notificados de violencia intrafamiliar, los cantones de la provincia con más casos, Puntarenas repiten Osa y Buenos Aires con más de un caso cada uno y donde hay más casos notificados de violencia intrafamiliar con tasas muy por encima de la nacional, finalmente tres cantones de la provincia de Limón muestran casos de femicidio.

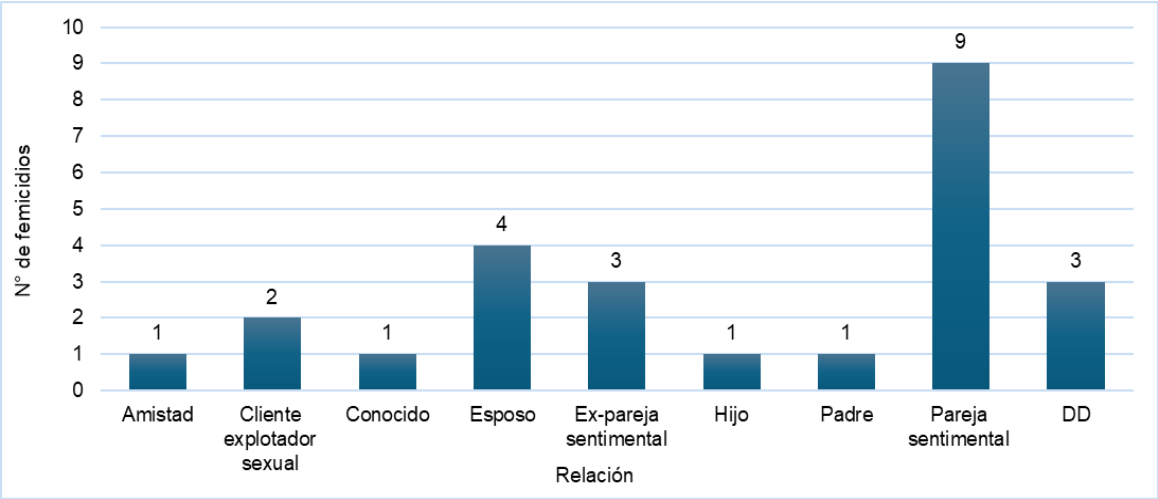
Tabla 1.
Costa Rica: casos de femicidios según cantón de ocurrencia por provincia, 2024

San José		Alajuela		Cartago		Heredia		Guanacaste		Puntarenas		Limón	
Cantones	N° casos	Cantones	N° casos	Cantones	N° casos	Cantones	N° casos	Cantones	N° casos	Cantones	N° casos	Cantones	N° casos
San José	1	Upala	1	Paraíso	1	San Pablo	1	Nicoya	1	Osa	2	Matina	1
Santa Ana	1	Alajuela	1			Santo Domingo	1	La Cruz	1	Parrita	1	Guácimo	1
Dota	1	San Carlos	1							Buenos Aires	2	Central	1
Goicoechea	1	Palmares	1							Coto Brus	1		
Montes de Oca	1									Garabito	1		
Desamparados	1												
Totales	***6***		***4***		***1***		***2***		***2***		***7***		***3***

Fuente: Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia

El gráfico 6, indica que, del total de 25 femicidios en Costa Rica al 12 de diciembre 2024, la mayor cantidad de casos según relación corresponde a la ***pareja sentimental*** como presunto femicida, seguido de la relación en donde el femicida es el esposo de la víctima y en una tercera posición corresponde a que el victimario fue la expareja. Está más que claro en este gráfico que la desigualdad, el machismo y misoginia, así la violencia doméstica entre otros aspectos a nivel de relaciones de pareja son los factores de riesgo que enfrentan las víctimas de femicidio en Costa Rica, a pesar de que hay otros tipos de relación como amistad, cliente explotador sexual, hijo, padre, etc, es la relación sentimental o marital la que indica que el peligro es permanente en el ámbito doméstico, sobre todo por el control y poder que estos ejercen sobre ellas.

Gráfico 6.
Costa Rica: casos de femicidios según relación con presunto femicida, 2024



DD: Dato Desconocido
Fuente: Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia

Finalmente, el gráfico 7, evidencia que el tipo de arma más utilizada para cometer femicidio es el arma blanca, le sigue otro tipo de armas (sin especificar) y en una tercera posición las armas de fuego, sin embargo, hay otras formas utilizadas e indicadas en dicho gráfico.

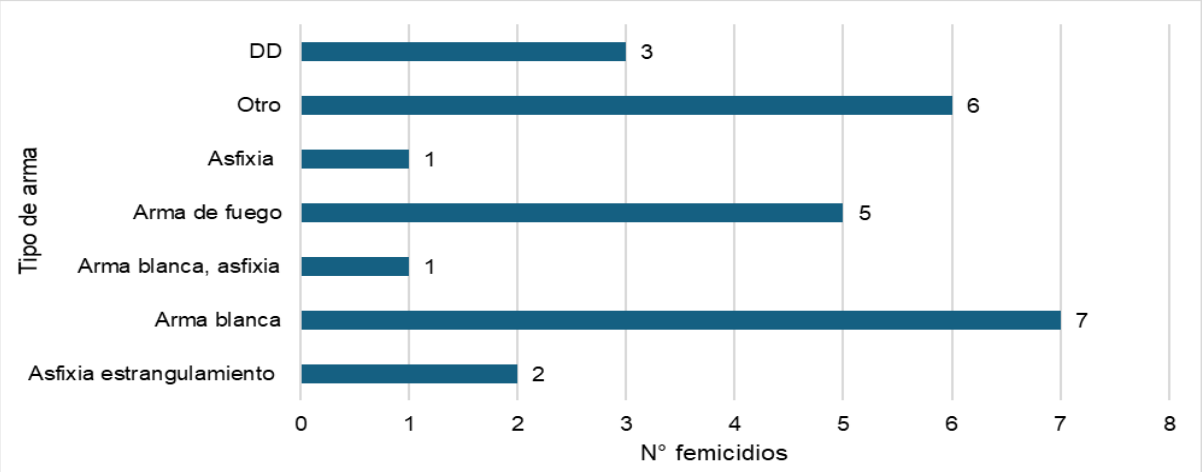
El uso de las armas blancas en femicidios es común por varias razones:

Accesibilidad: Las armas blancas, como cuchillos y navajas, son más accesibles y fáciles de obtener en comparación con las armas de fuego.

Intimidad del acto: El uso de un arma blanca requiere proximidad física, lo que puede reflejar la naturaleza personal y emocional del crimen.

Silencio: A diferencia de las armas de fuego, las armas blancas no hacen ruido, lo que permite al agresor cometer el crimen sin alertar a otros.

Gráfico 7.
Costa Rica: casos de femicidios según tipo de arma utilizada, 2024



DD: Dato Desconocido
Fuente: Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia